



โครงการพัฒนาคุณภาพ

ดร.วรรณวิมล คงสุวรรณ

หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด และผู้ชำนาญการพิเศษ
งานการพยาบาลผ่าตัด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

5 ตุลาคม 2569
13:00-15:00น.

การสร้าง CQI



มองเห็น ปัญหา
อยากจะทำพัฒนาคุณภาพการบริการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และนโยบายขององค์กร

Step of Quality Development



1) Initial Quality Development: IQD

- รวบรวมข้อมูล, segment ข้อมูล, ดูแนวโน้มดีขึ้น-แย่ลง ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

2) Continuous Quality Development: CQI

- การทำโครงการ ส่วนใหญ่ขาด Act = ไม่ทบทวนซ้ำ

3) Routine to Research: R2R

- งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ วิจัย
- Safer? – Better? – Faster?- Cheaper? – Easier?

4) Innovation in Quality Development : InQD

- Product & Process Innovation

Principle of Quality Management

Pain
point คือ
อะไร??

Quality Management

1

Focus on customer needs & expectations

2

Understanding work as systems and processes

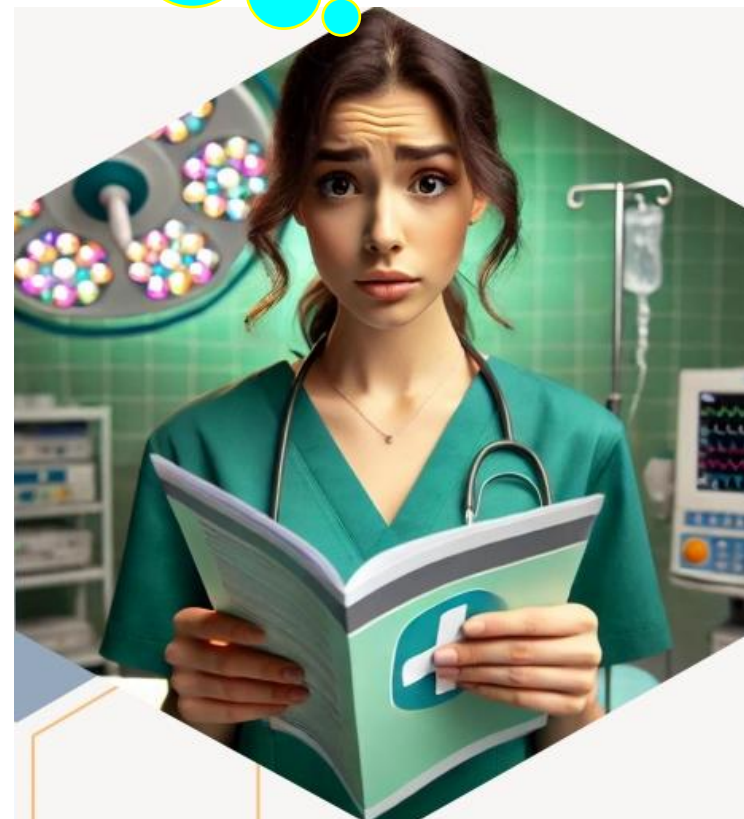
3

Focus on the use of data

4

Teamwork

การทำโครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม มิใช่ความบังเอิญ



Key Steps for Quality Improvement

Understand
the problem

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิด

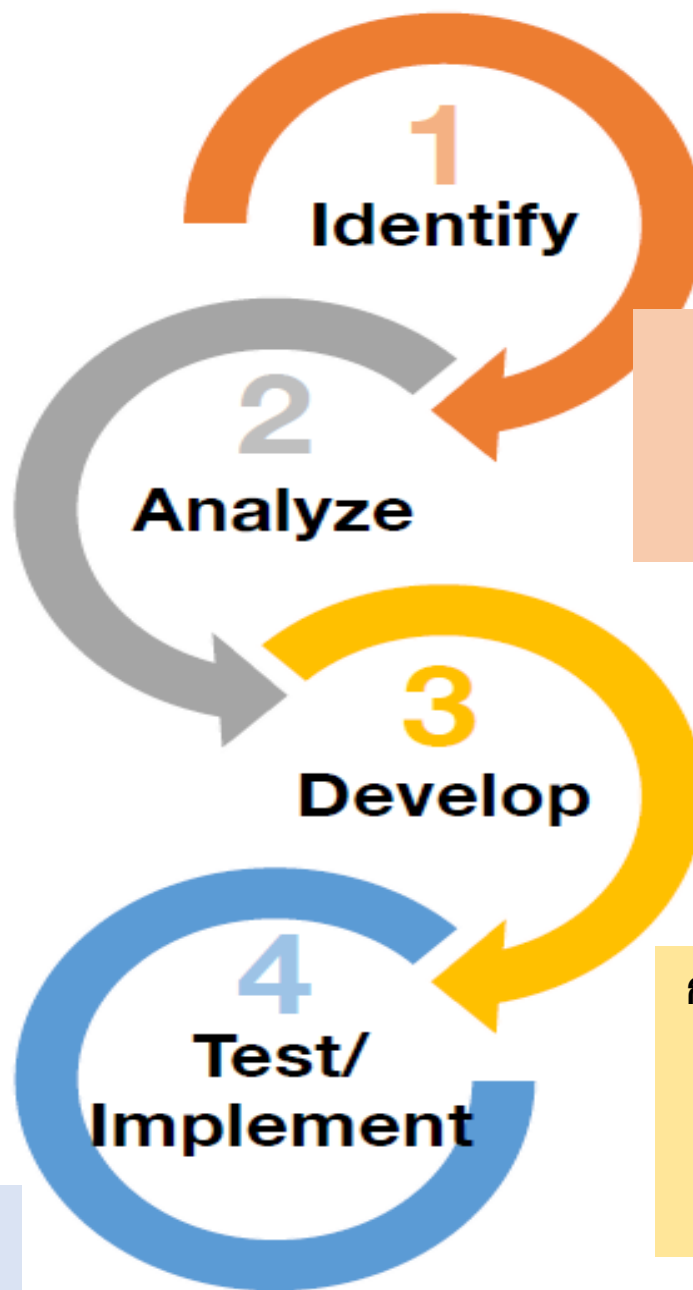
- PrI, VTE, Burn, Hypothermia, ...
- ความล่าช้าในการรักษา, การเข้าถึง
- สิ่งตกค้าง, specimen error

บุคลากรบาดเจ็บทางชีวภาพ/กายภาพ

Test the hypothesized solution.
Decide whether to abandon,
modify, or implement the solution

การสร้างแนวทางปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัด และทดสอบ
เพื่อวัดผล

ถ้าได้ผล-นำไปใช้ต่อ ถ้าไม่ได้ผล-ปรับปรุง/ยกเลิก



1
Identify

Determine what
to improve

ผู้ป่วยต้องการความปลอดภัย
★ ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
ต้องปลอดภัย
บุคลากรต้องปลอดภัย

2
Analyze

3
Develop

Hypothesize what
changes will improve
the problem

4
Test/
Implement

การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด
PrI, VTE, Burn, Hypothermia,
Fast track, specific screening
หรือสิ่งประดิษฐ์บางอย่าง
จะได้ผลไหม?

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ปัญหา

- เกิดขึ้นจริง หรือ near miss
- ยังไม่เกิด แต่มีความเสี่ยงจึงต้องป้องกันไว้ก่อน
เช่น การปฏิบัติไม่เหมือนกัน ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน

ข้อมูล/ สถิติ/ อ้างอิง

- หลักฐานยืนยันที่ความสำคัญของปัญหา เช่น
 - สถิติอุบัติการณ์
 - Recommended practice/ ผลการวิจัย

สาเหตุ

- ตรงกับประเด็นปัญหา
- แก้ไขที่สาเหตุที่มี Impact สูงก่อน
- เป็นบทบาทของพยาบาลโดยตรง (Autonomy)/ สหสาขา

การแก้ไข/ ป้องกัน

- ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ: PDCA, Lean, นวัตกรรมต่างๆ etc.
- **Process** : Guideline, CNPG, MEWS
- **Product** : สิ่งประดิษฐ์

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

- ตรงกับปัญหา&วัตถุประสงค์
- เลือกประเภทตัวชี้วัดที่เหมาะสม
- ออกแบบวิธีการเก็บตัวชี้วัดที่เที่ยงตรง

ประเมินผล

- ทดลองปฏิบัติ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล

สร้างโครงการพัฒนาคุณภาพ ได้อย่างไร



4 ขั้นตอนการสร้างโครงการ CQI

1) ตั้งประเด็นที่ใช้ และ ชัดเจน

- ⇒ เป็นปัญหาสำคัญของงานที่ทำจริงๆ
- ⇒ กำหนดผู้รับผลงาน และผู้ที่ใช้งานให้ชัดๆ
 - ⇒ พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้รับผลงาน ((Brainstorming))
 - ⇒ หาข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา...เคยมีมาก่อนหรือไม่??
 - ⇒ ทรัพยากรอำนาจ (ทุน) แต่...ต้องคิดนอกกรอบ
- ⇒ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ / ทฤษฎี/ งานวิจัยสนับสนุน
จะเจ๋งมาก

2) ออกแบบ สร้าง CQI (Intervention)

⇒ พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้รับผลงาน
((Brainstorming))

⇒ เปิดใจกว้าง เพราะ...ทุกความคิดเห็นคือโอกาสพัฒนา อย่ายึด
มันถือนั่น

⇒ ปรับเปลี่ยนได้หลายรอบ

⇒ ของเดิมมีไหม ? เป็นอย่างไร ?

⇒ ของใหม่ต่างจากเดิม/ ดีกว่าเดิมอย่างไร ?

⇒ ถ้าเป็นนวัตกรรม ต้องมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการประดิษฐ์จะดูดี



3) ทดลองใช้

- ➡ พิสูจน์จริง
- ➡ พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้รับผลงาน (ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน แพทย์)
- ➡ **ประเมินความปลอดภัย-ความเสี่ยง สำคัญที่สุด**
- ➡ ผลดี-ผลเสีย (คุ้มค่า คุ่มทุน)

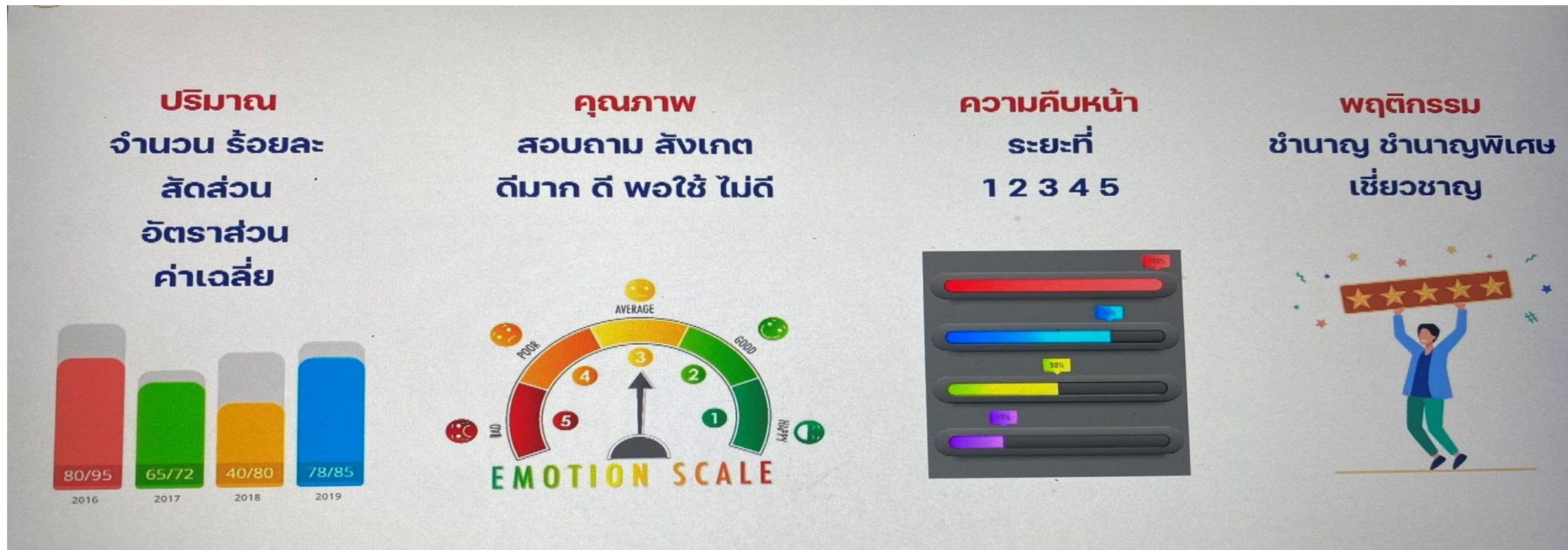
ประเภทของสิ่งประดิษฐ์

- ➡ ไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยโดยตรง
 - ไม่อยู่ใน Operative field
- ➡ ใช้กับผู้ป่วยโดยตรง
 - ใช้ภายนอกร่างกายผู้ป่วย
 - ใช้ภายในร่างกายผู้ป่วย
 - อยู่ใน Operative field ต้องเป็น Medical grade & เข้าสู่กระบวนการ Sterilization ได้จริง

3) ทดลองใช้ (ต่อ)

➡ กำหนด ตัวชี้วัด

➡ ออกแบบการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เก็บตอนไหน?
ใช้แบบเก็บข้อมูล แบบประเมินอะไร?



ประโยชน์ของตัวชี้วัด

- ❖ สะท้อนความสำเร็จของโครงการ หน่วยงานและองค์กร
- ❖ สะท้อนความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น
- ❖ สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
- ❖ นำผลมาใช้ในการวางแผน และตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

[illegible][illegible]

ตัวชี้วัด (Indicator)

ประเภทของข้อมูล

- Subjective data : ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามตามรับรู้ของคน (แบบสอบถาม) เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก ความพึงพอใจ
- Objective data : ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือ (ทางวิทยาศาสตร์) ที่น่าเชื่อถือในการวัด เช่น อุณหภูมิ, Oxygen sat., การติดเชื้อ, การเกิด skin change, อัตราการหายใจ, standard scoring ต่างๆ เป็นต้น

* Pain score ???



ประเภทของข้อมูล

ตัวอย่าง ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้			
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับระดับ 2	0 ครั้ง	3 ราย/เดือน	0	0	0
2. อุบัติการณ์สิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด	0 ครั้ง	1 ครั้ง	Objective data		
3. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ (Compliance rate)	>80%	ไม่มี			
4. อัตราความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	≥80%	ไม่มี	Subjective data		
5. คะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	≥85%	Pre test			
6. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาล	≥85%	88 %			
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	90%	ไม่มี			

ตัวชี้วัด (Indicator)

ประเภทของข้อมูล

➤ Process Indicator

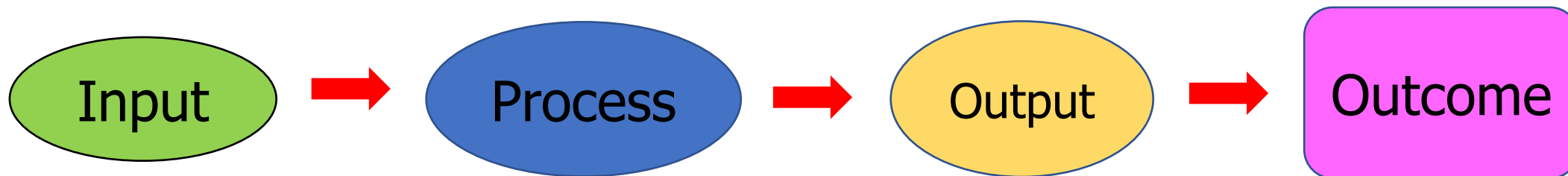
: ตัวชี้วัดกระบวนการ อาจจะเป็นตัวสำคัญ หรือไม่สำคัญก็ได้

➤ Key Performance Indicator

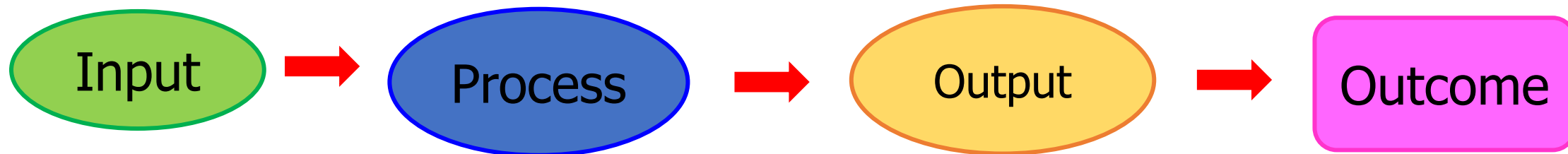
: ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนความสำเร็จของโครงการที่สุด ควรมี 1-3 ตัวเท่านั้น

ประเภทของตัวชี้วัด

- ❖ Process Indicator : ตัวชี้วัดกระบวนการ
- ❖ Output Indicator : ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการ
- ❖ Outcome Indicator : ตัวชี้วัดผลลัพธ์สุดท้าย



System Theory



Input	Process	Output Indicator/ Process Indicator	Outcome Indicator
CNPG ป้องกัน PI	การทำ MEWS เพื่อป้องกัน PI	- อัตราพยาบาลทำตาม guideline ถูกต้องครบถ้วน (90 %) (Compliance rate) Objective data	- อุบัติการณ์การเกิด Skin change - อุบัติการณ์เกิด PI
นวัตกรรมป้องกัน Hypothermia	- กระบวนการสร้างนวัตกรรม - วิธีการใช้นวัตกรรม	- อัตราการใช้นวัตกรรมกับผู้ป่วย 100% Objective data	- อุณหภูมิกาย >36 c - อุบัติการณ์เกิด Hypothermia
		Subjective data	- คะแนนความคิดเห็น ผป.รู้สึกสบาย >80 %

ตัวอย่าง



พว.สุธิสา ทิศอาจ, PI



กล่องปลดใบมิดของมีคม

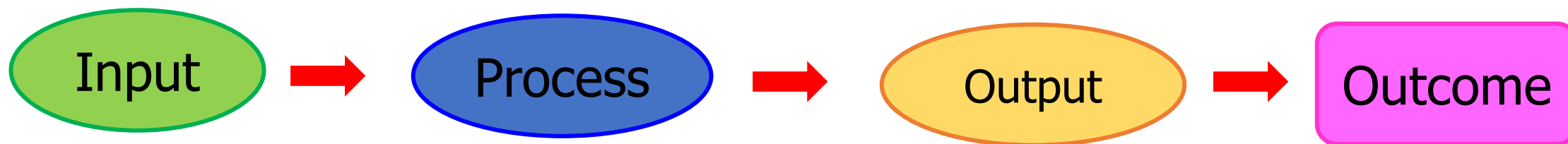
วัตถุประสงค์ ป้องกันบุคลากรบาดเจ็บจากของมีคม

ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ของการใช้งาน ?? คืออะไร วัดยังง

- รอบที่ 1
1. อุบัติการณ์บุคลากรบาดเจ็บจากของมีคม
(outcome indicator) & (objective data) เป็น **KPI**
 2. ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน
(process indicator) & (subjective data)

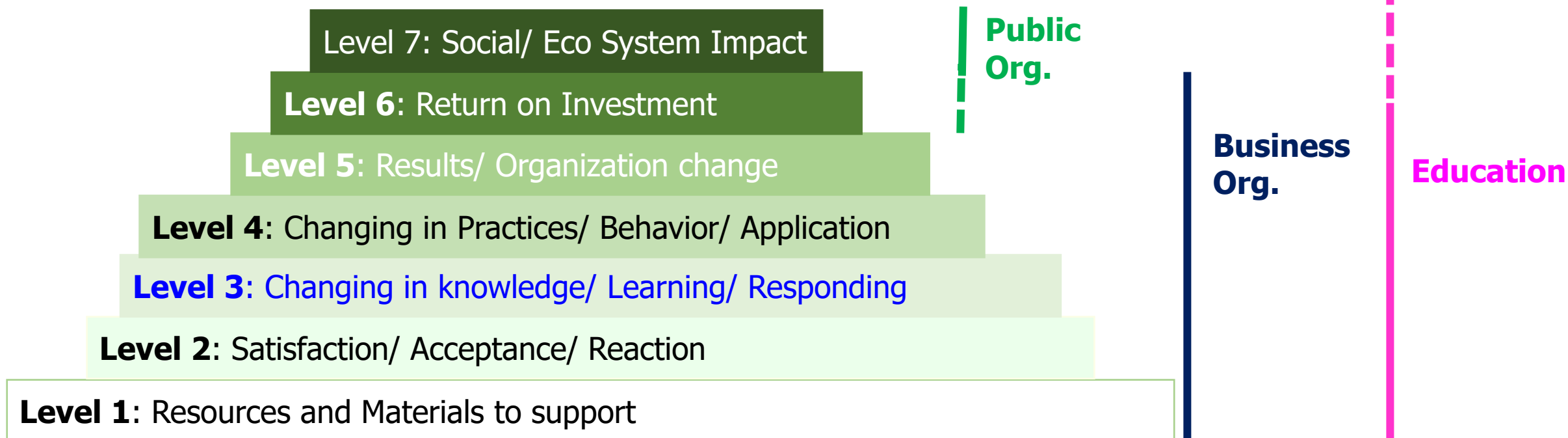
- รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
3. อัตราบุคลากรใช้กล่องปลดใบมิด
(process indicator) & (objective data)
 4. อัตราการปลดใบมิดออกจากด้ามมิดสำเร็จ
(output indicator) & (objective data)

System Theory



Input	Process	Output Indicator/ Process Indicator	Outcome Indicator
เนื้อหาความรู้ / ทักษะ	กระบวนการสอนอย่างมีแบบแผน	- อัตราผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตาม แผนที่กำหนด (>80%)	อัตราผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้/ ทักษะเพิ่มขึ้น

HR-OD-Organization Ecosystem Programs Evaluation





Comparison of perioperative outcomes and cost of robotic-assisted laparoscopy, laparoscopy and laparotomy for endometrial cancer

Pluvio J. Coronado ^{a,*}, Miguel A. Herraiz ^a, Javier F. Magrina ^b, María Fasero ^c, Jose A. Vidart ^a

^a Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Clínico San Carlos, Complutense University of Madrid, Spain

^b Department of Gynecologic Surgery, Mayo Clinic Scottsdale, AZ, USA

^c Hospital La Zarzuela Madrid, Spain

Table 2

Perioperative outcomes for the different surgery groups in patients with endometrial cancer.

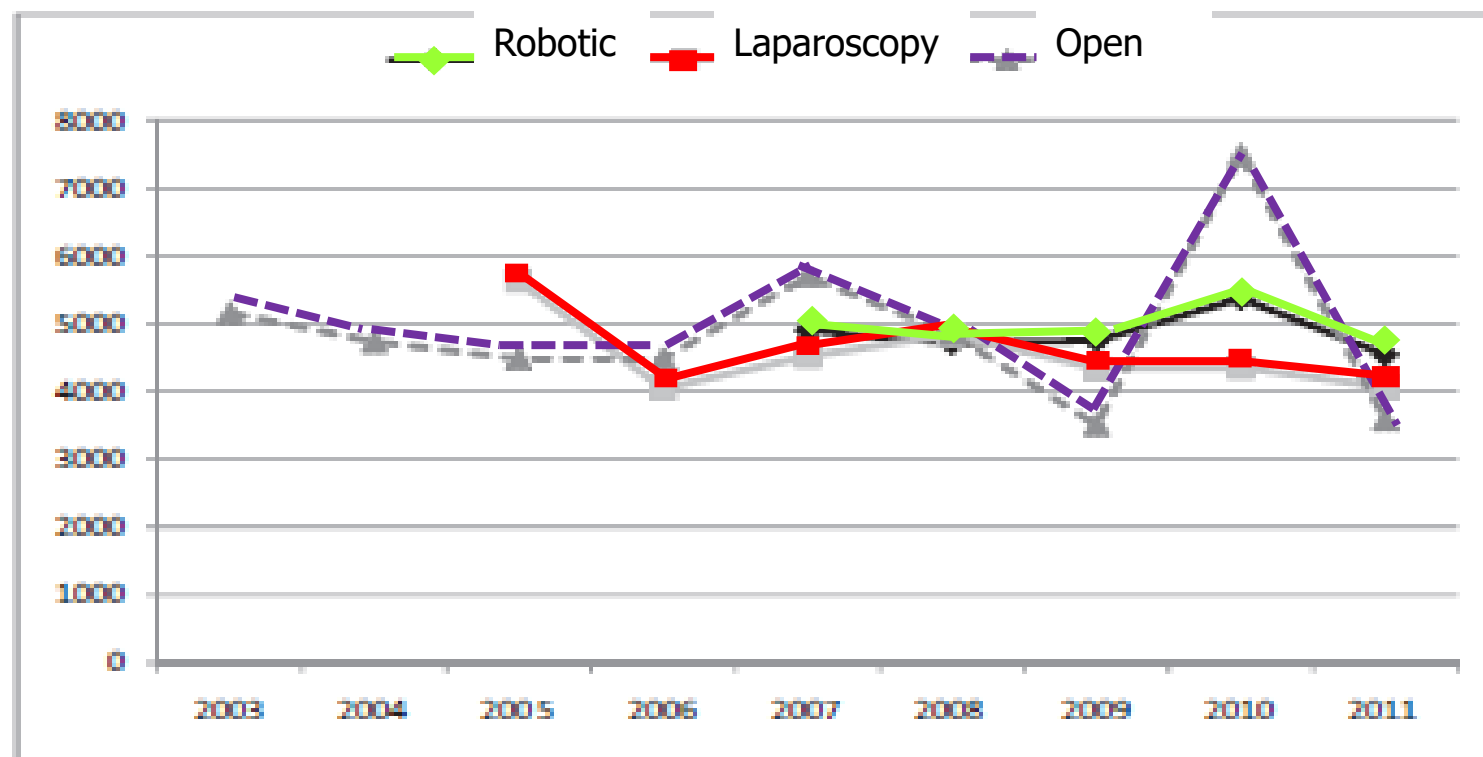
	Robotic N=71	Laparoscopic N=84	Open N=192	p value
Total pelvic nodes, Mean (SD) ^a	16.1 (7.6)	18.3 (7.8)	17.1 (8.0)	0.461
Total para-aortic nodes, Mean (SD) ^b	5.8 (2.1)	6.4 (4.0)	4.7 (2.2)	0.238
Operative time (min), Mean (SD)	189.2 (35.4)	218.2 (54.3)	157.4 (32.9)	0.000
Without lymphadenectomy	138.3 (45.6)	169.2 (49.9)	135.4 (38.9)	0.015 ^c
With lymphadenectomy	211.2 (48.9)	239.6 (61.8)	189.5 (42.6)	0.000 ^c
Estimated blood loss (ml), Mean (SD)	99.4 (75.4)	190.0 (119.7)	231.5 (109.5)	0.000 ^c
Difference of hemoglobin, Mean (SD)	−1.3 (0.9)	−2.3 (1.2)	−2.5 (1.3)	0.000 ^c
Transfusions, N (%)	3 (4.2)	6 (7.1)	27 (14.1)	0.036
Conversion to laparotomy, N (%)	3 (2.4)	7 (8.3)	–	0.181
Adhesions	2	3		
Obesity	0	2		
Length of hospital stay (days), Mean (SD)	3.5 (3.4)	4.6 (4.0)	8.1 (4.8)	0.000 ^c
Bladder injury	0	1		
Total complications, N (%)	15 (21.1)	24 (28.5)	67 (34.9)	0.079 ^d

Table 3

Disease-free and overall survival in the prospective series.

	Disease-Free Survival ^a	HR (95CI) ^b	Overall survival ^c
Robotic (n = 71)			
1 year	96.7%	0.67 (0.17–5.61)	95%
2 years	92.0%		95%
3 years	92.0%		95%
Laparoscopy (n = 58)			
1 year	91.0%	0.78 (0.24–2.46)	100%
2 years	87.1%		100%
3 years	83.1%		100%
Open (n = 38)			
1 year	90.3%	1	93.6%
2 years	77.4%		93.6%
3 years	38.7%		93.6%

การเปรียบเทียบราคา



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Robotic	0	0	0	0	2	8	20	25	16
Laparoscopy	0	0	10	10	19	13	11	9	12
Open	39	38	29	31	17	18	9	5	6

Fig. 1. Cost in euros of the three surgical approaches in the treatment of endometrial cancer along the years, $P > 0.1$.



แนวทางการเพิ่ม Cost Effectiveness

1. Improve workflow

- ☺ กำหนด Best practice + ตั้งเป้า cost per procedure (Saving 1.25-3% of operating expense)*
- ☺ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่นำไปสู่การเพิ่มผลลัพธ์ ลดกิจกรรมที่ไม่ได้วางแผนไว้ (Saving 0.5-1.5% of operating expense)*

2. Resource standardize and utilization

- ☺ จัดทำแนวปฏิบัติมาตรฐานเกณฑ์การคัดเลือก และใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ และ inventory control (saving .25-0.5% of operating expense)*

3. Performance management (Strategic management)

- ☺ การทำตัวชี้วัด และ เป้าหมาย เช่น
 - อัตราการเริ่มผ่าตัดตรงเวลา
 - ระยะเวลาในการเตรียมและทำความสะอาดห้องผ่าตัดต่อราย (turnover time)

3) ทดลองใช้ (ต่อ)

- ⇒ กำหนด ตัวชี้วัด แบบ subjective data & objective data ที่ชัดเจน**
- ⇒ ออกแบบการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- ⇒ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- ⇒ สรุปผลการทดลอง ควรใช้กระบวนการวิจัยเพื่อป้องกันอคติในการสรุปผล และเพื่อความน่าเชื่อถือ

4) ขยายผล

- ⇒ เอามาใช้จริง
- ⇒ นำเสนอผู้บริหาร
- ⇒ บอกเล่าความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ⇒ ขยายผลเชิงพาณิชย์ (เพิ่มมูลค่า)
 - ⇒ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

- 1) ปัญหาไม่ชัดเจน มีหลายปัญหา
- 2) ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน
- 3) การแก้ไข (Intervention) ไม่ได้แก้ปัญหา

- **กระบวนการทำงาน**

- ความซ้ำซ้อน มีการบันทึกหลายที่ เพิ่มภาระงาน
- Compliance ของบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม/ทำบางส่วน ไม่ยั่งยืน

- **สิ่งประดิษฐ์**

- ขาดการตรวจสอบ เพื่อยืนยันให้ได้ว่าปลอดภัยกับผู้ป่วยจริง

- 4) ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- 5) ตัวชี้วัดไม่ไวพอ เช่น

- วัดเฉพาะ Outcome indicator อุบัติการณ์เกิด/ ไม่เกิดเท่านั้น

- 6) ตัวชี้วัดที่กว้างเกินไป เช่น ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล/

ความพึงพอใจ/ ประสิทธิภาพ/ คุณภาพที่ดีขึ้น วัดได้อย่างไร??



**ปัญหา - วัตถุประสงค์ - การแก้ไข(Intervention) – ตัวชี้วัด
ต้องสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน**

ตัวอย่าง

Product
Innovation/(Improvement)

Pain Point !!

การจัดทำนอนผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัด

ปัญหา
!!!

ทำไมไม่ให้เกิด?

อันตรายกับผู้ป่วย ?

เกิดขึ้นแล้วต้อง
ทำอะไร ?

อุปกรณ์จัดทำไม่มี/
ราคาแพง ?



1) ตั้งประเด็นที่ใช้ และ ขัดเจน



- Area of Excellence CA Prostate
- ผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 120 ราย
พ.ศ. 2552 จำนวน 136 ราย, พ.ศ. 2553 จำนวน 150 ราย
- ยังไม่มีอุปกรณ์การยึดตรึงผู้ป่วยแบบนี้

☞ รอยถลอกจากการดึงพลาสติกออก

☞ รอยกดทับของพลาสติก

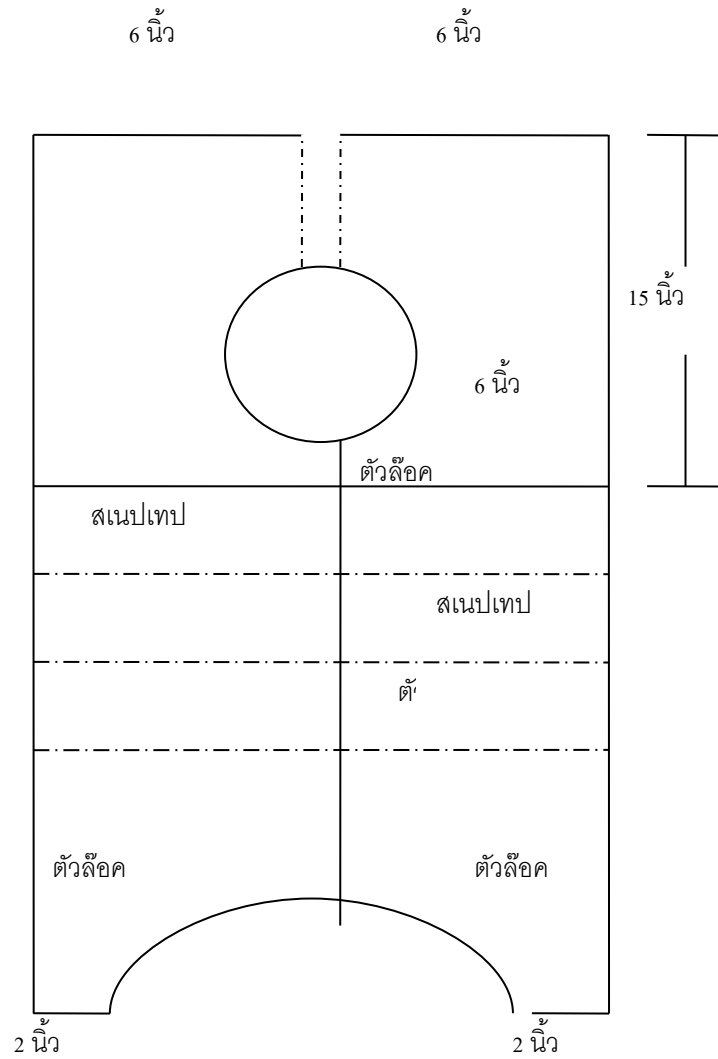
☞ อุบัติการณ์แพ้พลาสติก

☞ การกดหลอดเลือด (carotid artery) บริเวณคอ และหลอดเลือด

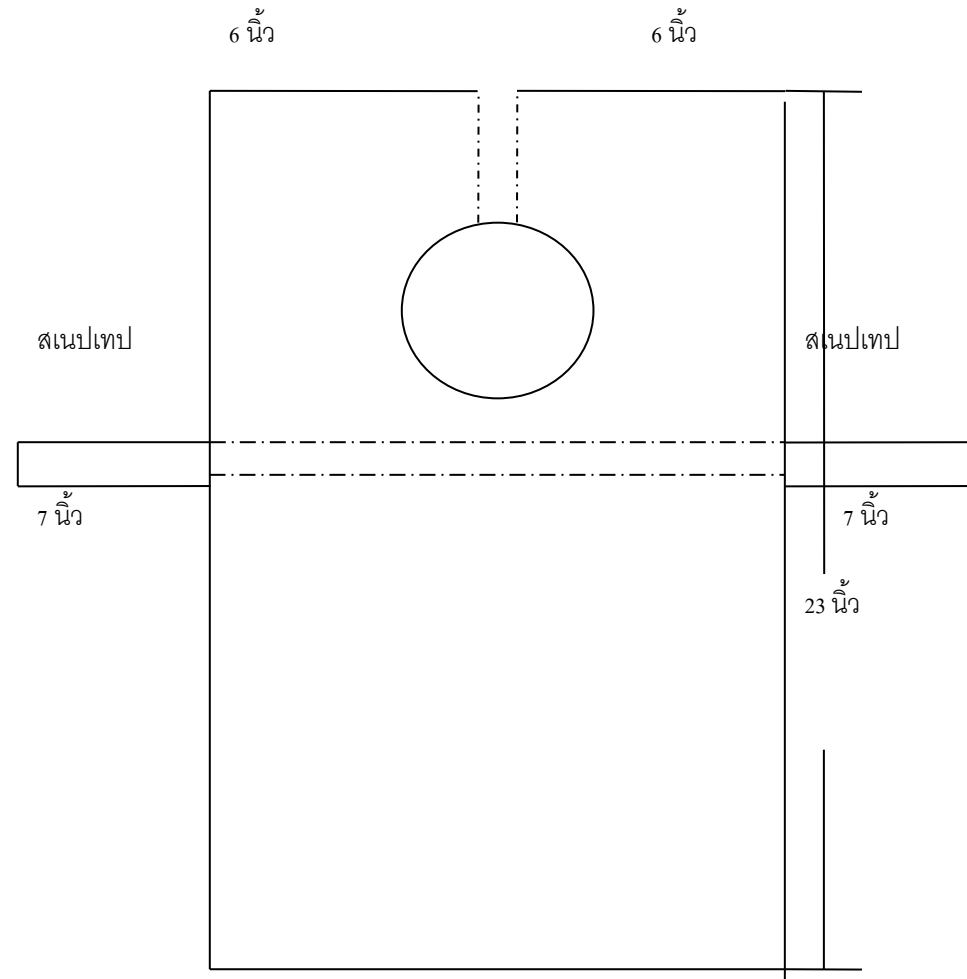
☞ แรงกดของพลาสติก ขัดขวางการขยายตัวของปอด

- ใช้พลาสติกเหนียวกว้าง 2 นิ้ว ยึดตรึงผู้ป่วย
- ปัญหาการแพ้พลาสติก
- เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจัดทำ
- ใช้พลาสติกจำนวนมาก (1 ม้วน : 2-3 คน)
- มีค่าใช้จ่าย

2) ออกแบบ สร้างนวัตกรรม



แบบเสื้อด้านหน้า



แบบเสื้อด้านหลัง

3) ทดลองใช้เสื้อยึดตรึงผู้ป่วย



เทปรัดด้านหน้าบริเวณหน้าอก



เทปรัดด้านข้างลำตัว ทั้ง 2 ข้าง

3) ทดลองใช้เสื้อยัดtringผู้ป่วย



- การทดลองใช้เสื้อหุ่นกับบุคลากรห้องผ่าตัดผู้ชายที่มีรูปร่างขนาดต่างๆ น้ำหนักตัวในช่วง 60-90 กิโลกรัม ส่วนสูง 158-172 เซนติเมตร จำนวน 20 คน

พบว่าสามารถขยายเสื้อตามขนาดของร่างกายช่วงอกได้สะดวก ผู้ถูกทดลองสามารถหายใจได้สะดวก ไม่อึดอัด

- ตรวจสอบการเลื่อนตัวของผู้ถูกทดลอง

พบว่าเสื้อสามารถยัดtringผู้เข้าร่วมทดลองได้ดี ไม่มีการเลื่อนไหลลงจากตำแหน่งเดิมที่นอนอยู่

การประเมินผลการใช้งาน



ตัวชี้วัด (KPI) Objective data	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้	
		ปี 2552	ปี 2553
<u>ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์หลัก</u> 1. อุบัติการณ์ ผู้ป่วยเลื่อนหล่นจากเตียงผ่าตัด	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
<u>ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์รอง</u> 2. อุบัติการณ์เกิดรอยกดทับที่ผิวหนัง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง

ใช้กับผู้ป่วยจริงน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 60-90 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ย 75.7 กิโลกรัม
ส่วนสูงอยู่ในช่วง 159-175 เซนติเมตร ส่วนสูงเฉลี่ย 168.5 เซนติเมตร

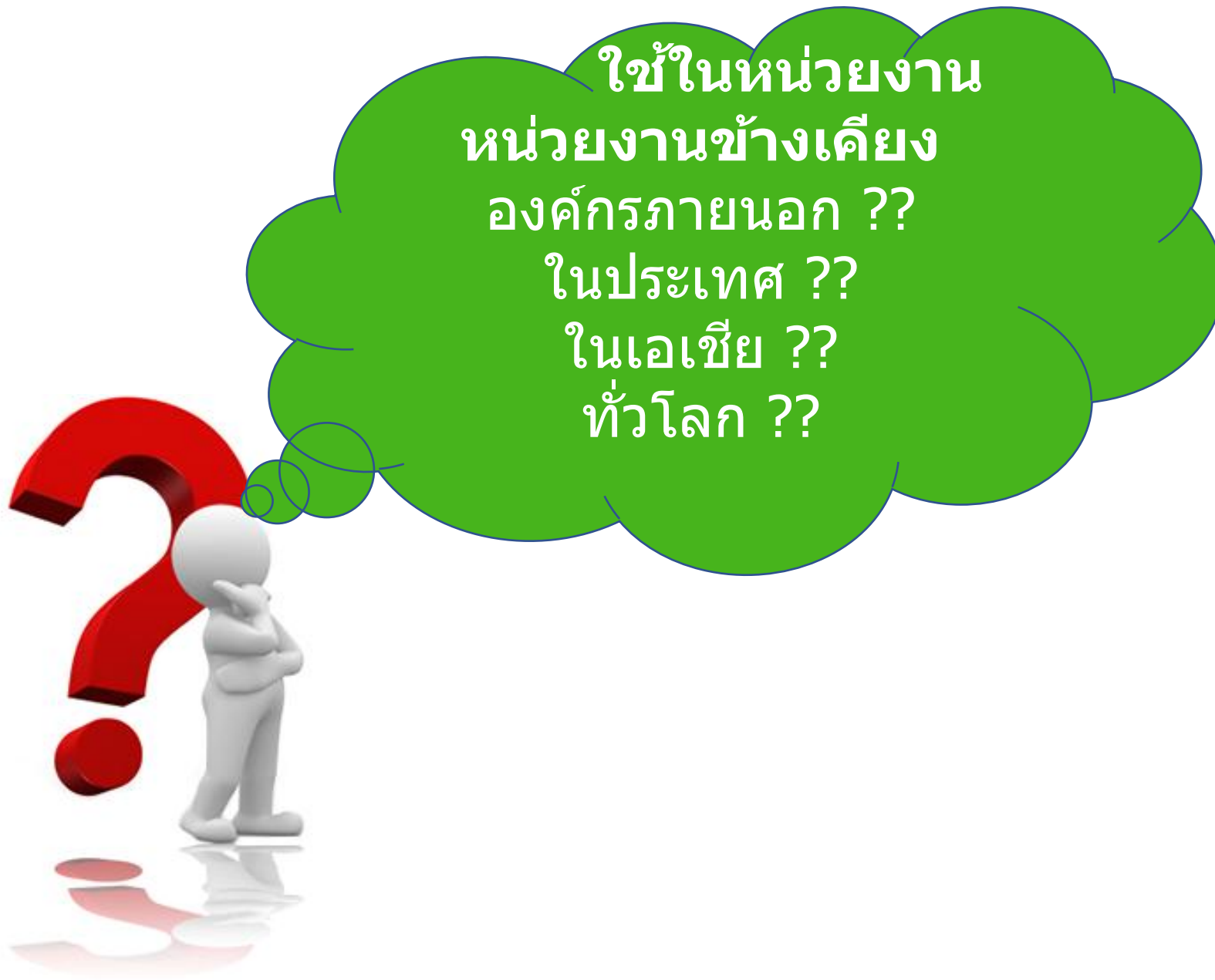
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งาน

รายการประเมิน Subjective data	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
1. อุปกรณ์นี้สามารถยึดตรึงผู้ป่วยได้	100%			
2. อุปกรณ์มีขนาดเหมาะสม	100%			
3. อุปกรณ์นี้สะดวกต่อการใช้งาน	100%			
4. อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้กับผู้ป่วย	100%			
5. ความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์	100%			

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตอบแบบสอบถาม:

ศัลยแพทย์ 10 คน, ทีมวิสัญญี 10 คน, พยาบาล 10 คน, ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน

4) ขยายผล



4) ขยายผล เสียดตริงผู้ป่วยในท่า Tenderlanburg position ขณะผ่าตัด

- ใช้ในหน่วยงาน และหน่วยงานข้างเคียง
- ส่งเข้าประกวดโครงการติดตาม ใต้นวัตกรรมดีเด่น
- แนะนำให้จดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
- เข้าโครงการฉลาดคิด by Siriraj
(www.creativesiriraj.com)
ขายสินค้านวัตกรรม 2,500 บาท
- นำเสนอภายนอกองค์กร



เสื้อยืดตรึงผู้ป่วยในท่า Tenderlanburg position ขณะผ่าตัด



หมอนรองรับขาและเท้า ใช้รองหนุนให้เท้าวางอยู่ในตำแหน่งที่แพทย์/เจ้าหน้าที่ทำงาน
หัตถการในการทำแผลบริเวณขาหรือเท้าได้สะดวก และผู้ป่วยใช้พาดเท้าได้สบายขึ้น
Foot's sofa เป็นงานนวัตกรรมที่ออกแบบประดิษฐ์โดยบุคลากรศิริราช สามารถนำไปใช้
ในงานของโรงพยาบาล เช่น หน่วยงานที่มีการทำหัตถการบริเวณขาและเท้าให้ผู้ป่วย
นอกจากนี้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้งานเองได้ที่บ้านด้วย



รถเข็นนั่งปรับยืนเพื่อผู้พิการท่อนล่าง (Stand up wheelchair)

นวัตกรรมรถเข็นนั่งปรับยืน จากโครงการ Siriraj stand up wheelchair สามารถปรับให้
ยืน นั่งได้สะดวกโดยผู้ป่วยเอง ลดการหดรัดข้อสะโพกข้อเข่า และช่วยบริหารกล้ามเนื้อ
ขา โดยคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ได้ไม่แพ้ของญี่ปุ่น มีความมั่นคงและปลอดภัย
ผู้ป่วยสามารถเพิ่มโอกาสการออกกำลังกายประจำวันในท่ายืนได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพจิตดีขึ้นเป็นลำดับช่วยลดผลกีดกัน การหดรัดข้อสะโพกข้อเข่า และช่วยบริหาร
กล้ามเนื้อขา พื้นผู้ป่วยอย่างได้ผล



เตียงยึดตรึงผู้ป่วยกับเตียงผ่าตัด

เตียงยึดตรึงผู้ป่วยกับเตียงผ่าตัด เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการยึดและตรึงตัวผู้
ป่วยไว้กับเตียงผ่าตัดในท่าศีรษะต่ำ เช่น ใช้ใน case Laparoscopic radical
prostatectomy, case CA bladder เป็นต้น เตียงนี้สามารถปรับใช้ได้ตามขนาดตัวของผู้
ป่วย ทำด้วยวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะในการนำมาใช้ทดแทนวิธีการดั้ง
เดิมที่ใช้พาสเตอร์ หรือ ผ้า ในการรัดตรึงตัวผู้ป่วยกับเตียงผ่าตัด



ชุดน้ำยาตรวจโรคเท้าช้าง (FilariaDIAG)

ชุดน้ำยาตรวจโรคเท้าช้าง (FilariaDIAG) ผลงานวิจัยของบุคลากรศิริราช ที่คิดค้นขึ้นเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหา การเจาะเลือดผู้ป่วยในยามวิกาลเพื่อนำมาวินิจฉัยโรคเท้าช้าง ชุดน้ำยา
FilariaDIAG นี้เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี ELISA เพื่อหาแอนติบอดี
ชนิดไอจีจีเอฟ ในน้ำเหลือง หรือ พลาสมา ของผู้ป่วย ให้ผลตรวจที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และ
แม่นยำ มีความไว และความจำเพาะเชื้อ filaria สูง ท่านสามารถเจาะเลือดผู้ป่วย ในเวลา
ใดก็ได้ โดยมีจำเป็นต้องออกเจาะเลือดผู้ป่วยในยามค่ำคืนอีกต่อไป

Poster Presentation

POSTER BOARD
The 3rd ASIORNA Conference 2012 & 5th ASIAN Perioperative Nursing Leadership Forum
August 30th - 1st September 2012
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

P-17

SURGICAL GARMENT FOR FIXING THE PATIENT IN TRENDLENBURG POSITION
Dr. Wanvimol Kongsuwan and Miss Sunee Temdetanroad
Siriraj hospital, Faculty of Medicine, Mahidol university

Laparoscopic surgery has been increasingly used in urology especially laparoscopic radical prostatectomy. At present, robotic assisted surgery is another option for surgical treatment of prostatic cancer in order to enhance efficiency in surgery. At Siriraj Hospital, robotic assisted prostatectomy has been performed since 2007. Nine hundred and fifty patients have undergone this procedure, 150 cases per year on average. The data shows that this operation will continue to be popular in the future.

In laparoscopic radical prostatectomy and robotic assisted surgery, the patient has to be placed at about 45 degrees in the Trendelenburg position to help keep the abdominal organs away from the field of operation. Operation theatre staff have to secure the patient's body to the operating table to prevent the patient from sliding down the bed. In the past, 3 or 4 meters of 2-inch-wide adhesive plaster cloth (Neo tape) were used to strap the patient's chest to the table. This technique causes many problems including limited lung expansion due to over-tight strapping, redness on the skin or plaster pressure sores, and the risk of an allergic reaction to the plaster.

Therefore, the positioning device to fix the patient to the operating table to prevent patients from sliding during procedures in the Trendelenburg position has been invented to reduce those risks and to lower the cost of adhesive plaster cloth.

Figure 1
Surgical garment

Tailoring method:

1. Design the pattern and locate the sites to attach the straps, then trace the outline on the paper.
2. Place the paper on black PVC coated fabric and cut it according to the pattern.
3. Sew the PVC coated fabric and put the sponge in as a lining.
4. Attach the straps and snap tape at the sites as shown in Figure 1.

Instruction:

Put the garment over the table in a half circle at the level of the patient's neck. After the patient has been anesthetised, fold the upper part of the garment to both shoulders and then place two straps in the middle with two snap tapes at the chest and three along each side. Experimentation on using the garment was performed with male staff members of the surgical team. Twenty men of different size and weight in the 60-90 kilogram range participated. The participants were set in the Trendelenburg position and tilted into low lithotomy position. The experiment showed that the garment was expandable and compatible to any chest size. It succeeded in securing the patient very well in head tilted positions. There was no sliding from the starting position.

After the experiment, a study using 20 actual patients was performed in January and February 2010. The patients weighed between 60-90 kilograms, 75.7 kg on average, and measured between 159-175 cm in height with an average of 168.5 cm. The study revealed that the garment was able to secure the patients to the operating table successfully. There was no incidence of the sliding from the table or redness on the skin from the pressure. Ten surgeons were asked for comments after using the device. All of them were greatly satisfied in terms of patient safety, appropriateness, and convenience. The overall satisfaction level was high. In addition, the garment has been used with different models of operating table and is suitable for all of them. The invention of this device is therefore helpful in the prevention of injuries that may occur during surgical procedures in the Trendelenburg position and it improves operating room service as well.



Oral Presentation



11th Asian Congress of Urology
"NEW ERA OF ASIAN UROLOGY"
22nd - 26th August, 2012
Royal Cliff Beach Resort & Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

Surgical precision advantage




FileEditViewFavoritesToolsHelp

EPSONWeb-To-PagePrintPrint Preview

Favorites(19 unread) - wanvimol7858 - Yahoo Mail

HomeMailNewsSportsFinanceWeatherGamesGroupsAnswersScreenFlickrMore

YAHOO!MAIL

Search MailSearch Web

wanvimol

INBOXCONTACTSCALENDARInternat...Poster...Present...Internat...Confir...Internat...

ComposeDeleteMoveSpamActions

Inbox (19)

Drafts (78)

Sent

Spam (20)

Trash

FOLDERS

MESSSENGER

Me: Offline

Sign in to Messenger to see who's online.

APPLICATIONS

Photos

Attachments

Notepad

comwave

Home Phone Line

International Forum on
QUALITY & SAFETY
in HEALTHCARE
London 2013

15 January 2013

Dear Wanvimol Kongsuwan

International Forum on Quality and Safety in Healthcare, April 2013, London

Thank you for agreeing to present your work as a poster display at the forthcoming International Forum on Quality and Safety in Health Care, which takes place which takes place from Tuesday 16 - Friday 19 April at ICC Excel, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, London, E16 1XL.

Poster title and Theme

Surgical garment for fixing the patient in trendalenburg position

Call for Abstracts (Surgery)

Registration

Please note that the Early Bird registration fee deadline is 31 January 2013 at 5PM GMT - after this date, the registration fee increases. All poster presenters will need to register for a minimum of three days attendance and pay the full registration fee. Posters are displayed from Wednesday 17 - Friday 19 April. Please note that there are no one day registration options for poster presenters. You can review the fees and register online at

http://internationalforum.bmj.com/home

The absolute final deadline for all poster presenters to register and pay to attend the Forum is Friday 22 February 2013. If you do not register and pay by this date we will regretfully

help where
it's needed most.



Support Oklahoma
Tornado Relief Efforts

Donate At:
unitedwayokla.org

ตัวอย่าง

Process
Innovation/(Improvement)

Pain point !!

การผ่าตัดฉุกเฉิน rAAA

ปัญหา
!!!

Emergency case
มานานกเวลา
ราชการ

Emergency case
รับ refer จากรพ.อื่น

เตรียมห้องผ่าตัด
ไม่ทัน?
เครื่องมือพิเศษ ?

หน.เวรได้ข้อมูล
case ไม่ครบถ้วน ?

โทร.ถามแพทย์
หลายรอบ ?

AN?
Admit ICU,
ward?

เตรียมเลือด?

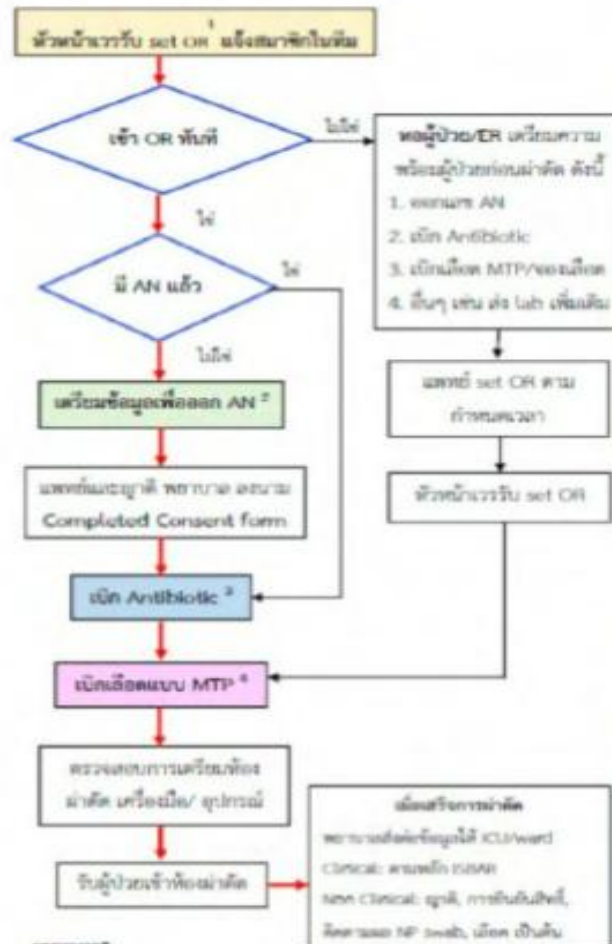
เบิก Antibiotic ?



โครงการ Perioperative Workflow of RAAA for Nurse



พว.วิจิตรา สังชะโห, PI



ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย 1 ตัวหน้าเวรรับเอกสารข้อมูลส่ง พญ.ผู้ป่วยพร้อม set OR ครึ่งที่ 1 1. ชื่อ-นามสกุล, นร, ปีการศึกษา 2. Clinical condition (On ET Tube) 3. Past Operation และ Special Requirement (ถ้ามี) 4. จัดแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย 5. พญ.ผู้ป่วยที่จะ Admit ผู้ป่วย เพื่อเตรียมห้องผ่าตัด AAA 6. Anesthetic ที่จะใช้ในห้องผ่าตัด 7. ยา Anesthetic MTP 8. Rapid Ag test ในห้องผ่าตัด 9. จัดแพทย์ผู้ set OR และเตรียมห้องผ่าตัด 10. เวลาที่ผู้ป่วยจะออกจากห้องผ่าตัด และระยะเวลาในห้องผ่าตัด 2 เมื่อผู้ป่วยจะถึงห้องผ่าตัดภายใน 30 นาที	ขั้นตอนการเตรียมห้องผ่าตัด AN 2 1. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 2. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการรับผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยไม่ผ่านการเตรียม ประสานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit กรณีผู้ป่วยอยู่บ้านในกรณีส่งมาห้องผ่าตัดเตรียมห้องผ่าตัด 3. กรณีผู้ป่วยที่ส่งมาห้องผ่าตัด เตรียมห้องผ่าตัด 4. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 5. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 6. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 7. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 8. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 9. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 10. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set
ขั้นตอนการเบิก Antibiotic 3 1. Rapid ในห้องผ่าตัด 2. ยา Anesthetic ที่เตรียม 3. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม set 4. 30min สำหรับเตรียมห้องผ่าตัด และเตรียมห้องผ่าตัด 5. พญ.ผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัด	ขั้นตอนการเบิกเลือดแบบ MTP 4 1. แพทย์ Activate MTP Test, 9-7098-9 และ Blood Bank 2. เตรียมแบบบันทึกการส่ง MACROVE TRANSFUSION PROTOCOL (ส่งตามทาง) 3. เตรียมเลือดแบบ MTP 4. พญ.ผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัด 5. พญ.ผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัด 6. พญ.ผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สืบค้นข้อมูลและทบทวนการทำงาน พร้อมจัดทำร่างโครงการฯ
2. ประชุมทีมเพื่อชี้แจงโครงการฯ
3. จัดทำแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดในการผ่าตัดฉุกเฉิน AAA สำหรับพยาบาลหัวหน้าเวร On Call (ภาพที่ 1)
4. จัดทำแนวปฏิบัติในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด Open Repair AAA และ EVAR (ภาพที่ 2)
5. ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 3, 4 เมื่อมีผู้ป่วยผ่าตัด
6. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 1)
7. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
8. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 2)
9. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
10. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 3)
11. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
12. เขียนสรุปโครงการฯ

เกณฑ์การคัดเข้า ODS program

ก่อนผ่าตัดที่ OPD

- Surgeon ตรวจวินิจฉัย
- Anes. ประเมินก่อนผ่าตัด (SiPAC)

Nurse Coordinator

- ประเมินผู้ป่วย: โรคร่วม, ยา ฯลฯ
- Health education
- ประสานงานและจัดการ
 - ส่งปรึกษา SiPAC
 - Consent form, สิทธิการรักษา
 - การนัดผ่าตัด
- เยี่ยมก่อนผ่าตัด ทางโทรศัพท์, line ID

Health literacy

วันผ่าตัด ที่ OR

ก่อนผ่าตัด OR Nurse

- ประเมินความพร้อม: NPO, allergy, Medication, ATB, previous surgery, pain control, urination, anxiety
- ทบทวนการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด
- Final verification

Anestheologist

- ชี้แจงวิธีการระงับความรู้สึก & ประเมิน

ขณะผ่าตัด

- พิจารณาการคัดออกจาก ODS program

หลังผ่าตัด

- Surgeon ประเมินผลลัพธ์การผ่าตัด และความพร้อมก่อนจำหน่าย
- Anes. ประเมินผลลัพธ์การระงับความรู้สึก และความพร้อมจำหน่าย

Entry



Assessment

Investigation

Diagnosis

Care plan

Discharge planning

Care Delivery (Pre & Post operation) Nursing/ Nutrition/ Medication/ Anesthesia/ rehabilitation/ Evaluation & Procedure

Re - Assessment

Discharge

Follow up

Patient Care Process: ODS



ประเมิน METHOD

- Self care ability
- ลักษณะที่อยู่อาศัย
- อุปกรณ์ดูแลต่อที่บ้าน
- link กับหน่วยพยาบาลต่อเนื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข, อสม, รพสต.

หลังผ่าตัด OR Nurse

- Monitoring & Evaluation, Wound & Pain management
- Start: drinking, Ambulation, Urination
- ประเมินความพร้อมก่อนจำหน่าย โดย PADSS
- Health education หลังผ่าตัด
- การนัดหมาย Follow up

หลังผ่าตัดที่ OPD

- Surgeon ประเมินผลลัพธ์การรักษา
- Nurse Coordinator หลังผ่าตัด
- ติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 3 รอบ (6 ชม.หลังผ่าตัด, หลังผ่าตัดวันที่ 1 และ 2) ทางโทรศัพท์
- ประเมินผลลัพธ์การบริการที่ OPD (delivery, Satisfaction, anxiety, health education)

Author	Type of surgery	Aim (s)	Finding	OR-Related Factors			Patient-Related Factors				
				duration	Positioning (device)	OR bed surface	Age, gender, BMI	Comorbidity (Heart, vascular)	Hypothermia	Baraen scale	
Connor et al, 2010, USA	Urology	To identify the predictive of PrI	5% developed PrI - 20% Sacral area - 16% Involved the flank - 12% involved the back	✓							
Primiano et al, 2011, USA	General, neuro, orthopedic, vascular, gynecologic, cardiothoracic	To identified prevalence of and risk factors associated with PrI	8.1% developed PrI								
Bulfone et al, 2012, Italy	General, neuro, cardiac, plastic, vascular	To explore the intraoperative PrI incidence and risk factors	15% developed PrI					✓	✓		
Nilsson, 2013, Sweden	ENT, plastic, oral	To identify risk factors associated with PrI	15% developed PrI								
Shaw et al, 2014, Taiwan	General, neuro, orthopedic, cardiac	To identify risk factors associated with PrI	15% developed PrI		✓		✓			✓	
Webster et al, 2015, Australia	General, orthopedic	To assess risk factors associated with PrI	1.3% developed PrI (66.7% st.1, 33.3% st.2)		✓		✓	✓			
Chen et al, 2017, China	Hepatobiliary surgery	To identify risk factors associated with PrI	- 19.8% in the immediate - 4.9% on the first day after s. - 4.1% on the second day	✓	Hypotensive episodes ✓						
Luo et al, 2019, China	Neuro	To measure the incidence PrI and risk factor in patients undergoing spinal surgery & prone position	4.7% developed PrI	✓			✓				✓

Systematic review
บทความทางวิชาการ
งานวิเคราะห์ (เทียบกับ OR เรา เป็นยังไง)



DEFINITION OF A PERIOPERATIVE PRESSURE INJURY

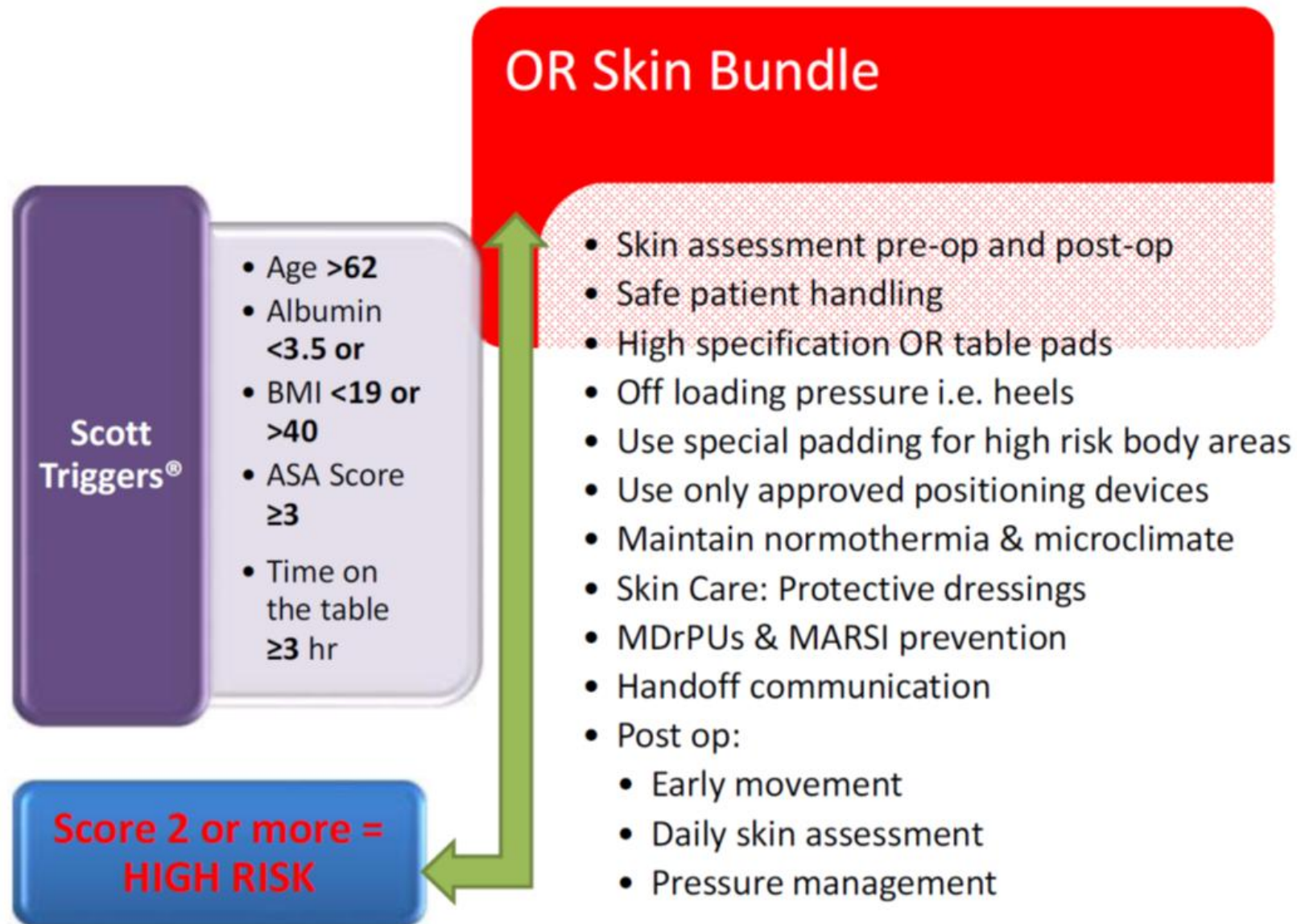
A perioperative pressure ulcer is normally defined as any tissue related injury that presents within 48-72 hours post-operatively and is associated with a surgical position

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42 (5) : 480-485.

Black, J., Fawcett, D., & Scott, S. Ten top tips: preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds International

2014;5(4). [Http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf](http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf). Accessed February 10. 2015.

Guideline for Perioperative Pressure Injury Prevention



Susan M. Scott
MSN, RN, WOCN
PS/QI Educator
University of Tennessee College of
Medicine
Office of Graduate Medical Education



พว. นพเก้า ชนะภัย
ET nurse
งานการพยาบาลผ่าตัด

Black J, Fawcett D. Scott S Ten top tips: Preventing pressure ulcers in the surgical patient. *Wounds International* 2014;5(4).
http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf. Accessed February 10, 2015.

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2015;42 (5);480-485.

Scott S. Creating a strategic plan for perioperative pressure ulcer prevention. *AORN Journal* 2016;103(4):13-14.

Modified Early Warning Sign (MEWS) for Perioperative Pressure Injury Prevention



Version 6

Sticker ผู้ป่วย

DEFINITION OF A PERIOPERATIVE PRESSURE INJURY

A perioperative pressure ulcer is normally defined as any tissue related injury that presents within 48-72 hours post-operatively and is associated with a surgical position

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42 (5) : 480-485.
Black, J., Fawcett, D., & Scott, S. Ten top tips: preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds International 2014;5(4). [Http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf](http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf). Accessed February 10, 2015.

OR Skin Bundle

Scott Triggers®

- Age >62
- Albumin <3.5 or >40
- BMI <19 or >40
- ASA Score ≥3
- Time on the table ≥3 hr

Score 2 or more = HIGH RISK

- Skin assessment pre-op and post-op
- Safe patient handling
- High specification OR table pads
- Off loading pressure i.e. heels
- Use special padding for high risk body areas
- Use only approved positioning devices
- Maintain normothermia & microclimate
- Skin Care: Protective dressings
- MDrPUs & MARSIs prevention
- Handoff communication
- Post op:
 - Early movement
 - Daily skin assessment
 - Pressure management

Black J, Fawcett D, Scott S Ten top tips: Preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds International 2014;5(4). http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf. Accessed February 10, 2015.
Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42 (5): 480-485.
Scott S. Creating a strategic plan for perioperative pressure ulcer prevention. AORN Journal 2016;103(4):13-14.

พว. นพเก้า ชนะภัย
ET nurse
งานการพยาบาลผ่าตัด



วัตถุประสงค์ : ป้องกันการเกิดแผลกดทับในห้องผ่าตัด

KPI

1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ≥ 80%
2. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด = 5 %
3. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 ในห้องผ่าตัด = 0 %

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด:
Siriraj Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign
For Perioperative Pressure Injury Prevention (1)

Previous Pressure Injury : ☐ No
☐ Yes : Stage... Site.....

High Risk : ☐ Operative time. ≥ 3 hrs
With risk factor ≥ 1

Position :
☐ Prone
☐ Park Bench/Lateral
☐ Lithotomy
☐ Supine

Age ≥ 62
BMI < 19 or > 40 (< 43.3 kgs or > 120 kgs.)
American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

OR Skin Prevention Bundle (5) (6), (6)

- ☐ Maintenance of normothermia
- ☐ Special padding
- ☐ Positioning Devices
- ☐ Polyurethane foam dressing (6)

Assessment: Skin changes (4) and Pressure injury (5) (6), (6)

Skin changes (4) / Pressure Injury (5) (6), (6)

☐ No
☐ Yes

Early Re-positioning (6) (6), (6) ☐ OR ☐ RR
Change positions of medical devices (7) (6) ☐ OR ☐ RR
Notify surgeon ☐ OR ☐ RR
Standard Nursing Care Pressure injury ☐ OR ☐ RR
Notify ward ☐ OR ☐ RR

Summary By: ☐ OR ☐ RR Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other.....

Skin changes : ☐ No
☐ Yes ☐ Redness ☐ Bruising ☐ Edema ☐ Dark skin area

Pressure injury : ☐ No
☐ Yes ☐ Pressure injury stage 1/2 ☐ DTPI ☐ MDRPI stage..... ☐ MMDPI

Other Wound : ☐ No
☐ Yes ☐ MARSIs site..... ☐ Trauma injury site.....

Diagnosis :

Operation :

Operative time : Incision..... Closure.....

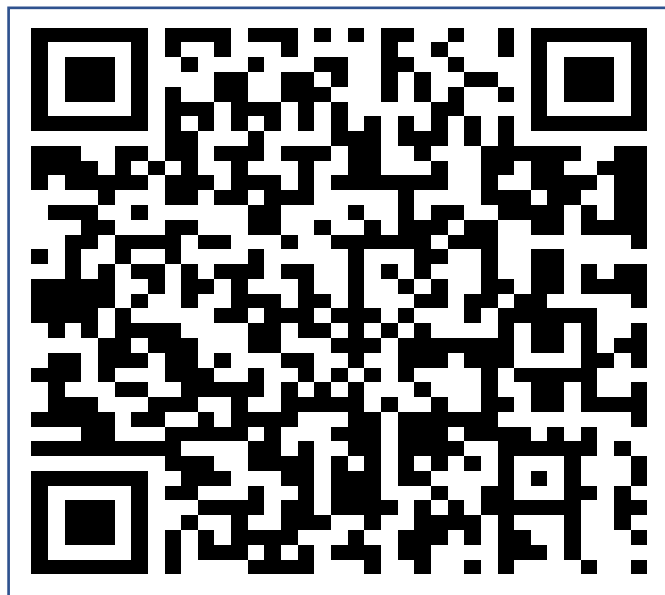
Date :

Sign RN :

การประเมิน MEWS: Perioperative PrI prevention โดย



AGREE GRS
(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation Global Rating
Scale)



การประเมิน MEWS: PrI prevention



รายการประเมิน Guideline โดย AGREE GRS

Process of Development

- 1) มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบในการพัฒนา Guideline
- 2) มีคณะทำงานกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา Guideline
- 3) มีข้อแนะนำที่สอดคล้องกับทฤษฎี และข้อมูลทางวิชาการ

Presentation Style

- 4) ข้อแนะนำใน Guideline ง่ายต่อการอ้างอิงหรือค้นหาเพิ่มเติม

Completeness of Reporting

- 5) ขบวนการพัฒนา Guideline มีความโปร่งใส
- 6) Guideline มีข้อมูลอย่างครบถ้วนทำให้ตัดสินใจได้ และทำซ้ำได้

Clinical Validity

- 7) Guideline มีข้อแนะนำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

Overall Assessment

- 8) การให้คะแนนคุณภาพโดยรวมของ Guideline
- 9) ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้มีการใช้ Guideline นี้ในการปฏิบัติงาน
- 10) ท่านจะใช้ Guideline นี้ในการตัดสินใจทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน MEWS: PrI prevention



ผู้ทำประเมินทั้งหมด 266 คน
RN 199 คน คิดเป็น 90.45%

Highest
Quality



Lowest
Quality

รายการประเมิน	7-5	7	6	5	4	3	2	1
1) มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบในการพัฒนา Guideline	80.1%	46 (17.3%)	84 (31.6%)	83 (31.2%)	35 (13.2%)	14 (5.3%)	3 (1.1%)	1 (0.4%)
2) มีคณะทำงานกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา Guideline	73.9%	40 (15%)	77 (28.4%)	81 (30.5%)	46 (17.3%)	13 (4.9%)	5 (1.9%)	4 (1.5%)
3) มีข้อแนะนำที่สอดคล้องกับทฤษฎี และข้อมูลทางวิชาการ	79.3%	44 (16.5%)	84 (33.5%)	78 (29.3%)	34 (12.8%)	18 (6.8%)	2 (0.8%)	1 (0.4%)
4) ข้อแนะนำใน Guideline ง่ายต่อการอ้างอิงหรือค้นหาเพิ่มเติม	73.6%	33 (12.4%)	90 (33.8%)	73 (27.4%)	47 (17.7%)	19 (7.1%)	2 (0.8%)	2 (0.8%)
5) ขบวนการพัฒนา Guideline มีความโปร่งใส	78.6%	55 (20.7%)	78 (29.3%)	76 (28.6%)	41 (15.9%)	13 (4.9%)	0	3 (1.1%)
6) Guideline มีข้อมูลอย่างครบถ้วนทำให้ตัดสินใจได้ และทำซ้ำได้	75.6%	40 (15%)	89 (33.5%)	72 (27.1%)	48 (18%)	11 (4.1%)	2 (0.8%)	4 (1.5%)
7) Guideline มีข้อแนะนำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย	76.8%	43 (16.2%)	89 (33.5%)	72 (27.1%)	44 (16.5%)	13 (4.9%)	3 (1.1%)	2 (0.8%)
8) การให้คะแนนคุณภาพโดยรวมของ Guideline	78.2%	40 (15%)	89 (33.5%)	79 (29.7%)	42 (15.8%)	11 (4.1%)	2 (0.8%)	3 (1.1%)
9) ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้มีการใช้ Guideline นี้ในการปฏิบัติงาน	79%	46 (17.3%)	85 (32%)	79 (29.7%)	39 (14.7%)	14 (5.3%)	2 (0.8%)	1 (0.4%)
10) ท่านจะใช้ Guideline นี้ในการตัดสินใจทางวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงาน	79.7%	54 (20.3%)	77 (28.9%)	81 (30.5%)	33 (12.9%)	16 (6%)	3 (1.1%)	2 (0.8%)

รายงานตัวชี้วัด โครงการ Perioperative Pressure related Injury prevention



รายงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์				
		ปี 2564				ปี 2565
		ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.
		N=944 ราย	N=540 ราย	N=565 ราย	N=1,093 ราย	N=1,115 ราย
1) อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	≥ 80%	85.17	90.37	90.80	92.31	91.21
1.1) อัตราการบันทึกข้อมูลในใบ MEWS ที่สมบูรณ์	≥ 80%	97.14	97.95	98.24	97.82	98.72
2) อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด	< 2 %	4.02 (38 ราย)	3.9 (21 ราย)	2.48 (14 ราย)	2.56 (28 ราย)	2.24 (25 ราย)
3) อัตราการเกิดแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในห้องผ่าตัด	0 %	1.16 (11 ราย)	1.30 (7 ราย)	1.24 (7 ราย)	0.73 (8 ราย)	0.45 (5 ราย)

หมายเหตุ* ปี 2564 - มีสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่สาม เริ่ม เมษายน-พฤษภาคม

งานสังเคราะห์:

งานที่รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ สร้างรูปแบบ หรือโครงสร้าง เบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทาง หรือเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

(Mini) Quasi-Experimental research

การประเมินผล Infographic: Pressure injury Prevention and Management



ผู้ทำการประเมินทั้งหมด 395 คน คิดเป็น 90.39 %

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	1 น้อยที่สุด	2	3	4	5 มากที่สุด
1) Infographic นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Pressure Injury in OR ครบถ้วน	0	2	22	163	208
		0.5%	5.6%	41.3%	52.7%
2) Infographic นี้มีตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย	3	8	51	164	169
	0.8%	2%	12.9%	41.5%	42.8%
3) Infographic นี้มีภาพประกอบที่ชัดเจน ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น	2	9	29	164	191
	0.5%	2.3%	7.3%	41.5%	48.4%
4) ท่านสามารถนำความรู้จาก Infographic นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยได้	1	4	29	169	192
	0.3%	1%	7.3%	42.8%	48.6%
5) ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้ใช้ Infographic นี้ช่วยในการปฏิบัติงาน	1	4	27	164	199
	0.3%	1%	6.8%	41.5%	50.4%

Localized damage to skin and underlying soft tissue, usually over **bony prominence** or related **medical device**



A perioperative pressure injury is normally defined as any tissue related injury that presents **within 48-72 hours post-operatively** and is associated with a surgical position

Pre-operative

Intra-Post operative

Input Problem	Intervention (Process/ Product)	Output Indicator/ Process Indicator	Outcome Indicator
CNPG ป้องกัน PrI (ยังไม่มี guideline ที่ชัดเจน)	การทำ MEWS เพื่อป้องกัน PrI	- อัตราพยาบาลปฏิบัติตาม guideline ถูกต้องครบถ้วน (90 %) (Compliance rate)	- อุบัติการณ์การเกิด Skin change - อุบัติการณ์เกิด PrI ระดับที่ 1 และ 2
เนื้อหาความรู้ /ทักษะ (Competency เรื่อง การป้องกันการเกิดแผล และการจัดการแผลในหอผ่าตัดยังน้อย)	กระบวนการสอนอย่างมีแบบแผน	- อัตราผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด (>90%)	- อัตราผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้/ ทักษะเพิ่มขึ้น (>90%) - อัตราบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะเรื่องการจัดการ PrI (ประเมิน-ป้องกัน-ดูแลแผล) (> 90%)
สิ่งประดิษฐ์ป้องกัน การเกิด PrI (อุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ ต้องประดิษฐ์ช่วย)	- กระบวนการสร้างนวัตกรรม - วิธีการใช้นวัตกรรม	- อัตราการใช้นวัตกรรมกับผู้ป่วย 100%	- อุบัติการณ์การเกิด Skin change - อุบัติการณ์เกิด PrI ระดับที่ 1 และ 2 - ความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์

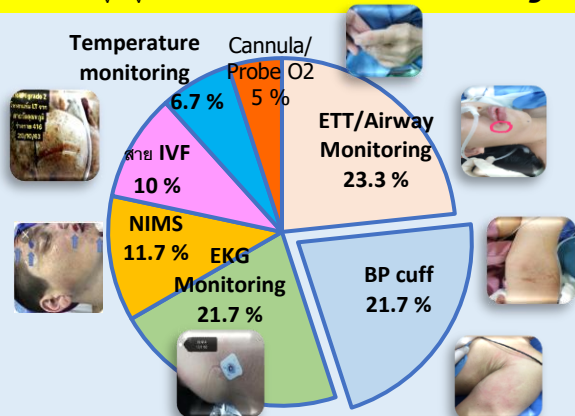
งานวิเคราะห์:

งานที่ แยกแยะองค์ประกอบต่างๆอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
(Mini) Descriptive research

1) ผลกตหับที่เกิดจากอุปกรณ์การแพทย์

MDRPI

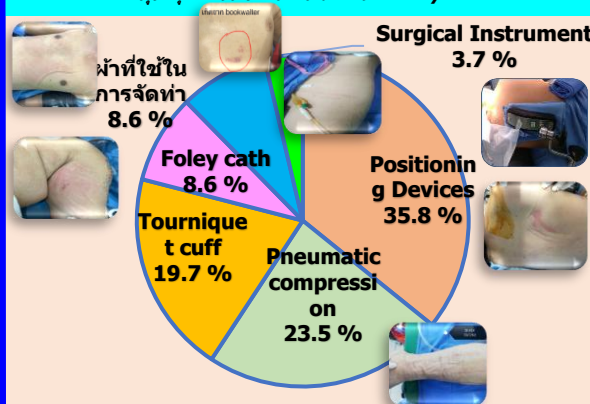
กลุ่มอุปกรณ์ **Anesthesia and monitoring**



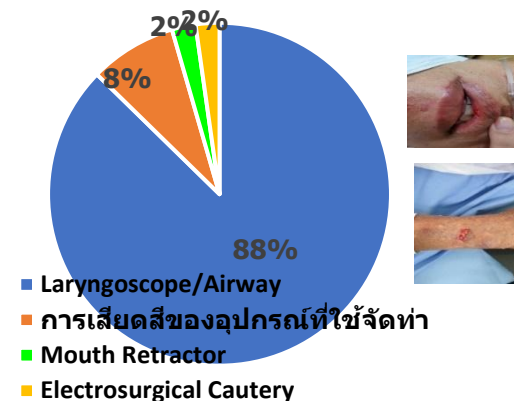
2) ผลกตหับที่เกิดจากอุปกรณ์การแพทย์

MDRPI

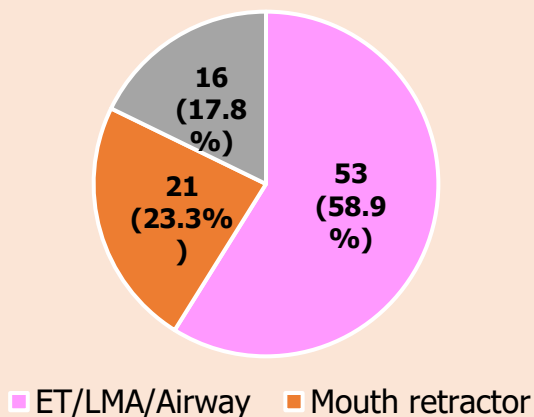
กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท่า/ ทำผ่าตัด



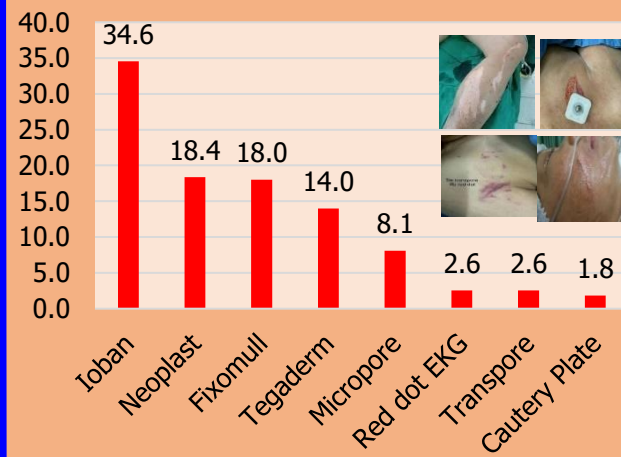
3) สาเหตุการเกิด Trauma injury



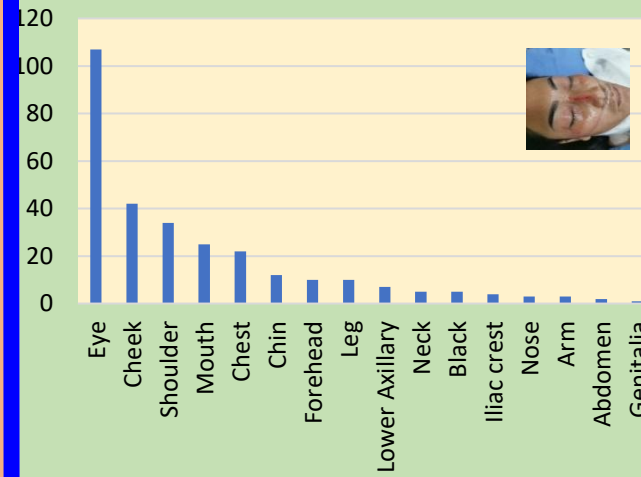
4) อุปกรณ์การแพทย์ที่ทำให้เกิดแผล **MMPI**



5) ประเภทของ Adhesive ทำให้การเกิด MARSI



5) ตำแหน่งการเกิด MARSI



งานพัฒนาคุณภาพจาก ...
การรับเยี่ยมชมสำรวจ
Risk round, IC & ENV
round
Audit กระบวนการทำงาน,
document



Pain point !!

ทำไม? มีน้องไม่ปฏิบัติตาม WI

ปัญหา
!!!

ฟอกมือนานเกินไป ทำ
ขั้นตอนต่อไปไม่ทัน

ไม่ใช้แปรงก็
สะอาดพอ

เห็นแพทย์
(บางคน) ก็ไม่
ใช้แปรง

แปรงชุดผิวหนัง
เจ็บ !!

การหยิบแปรง
ไม่เหมือนเดิม

เปิดช่องแปรงที่ 2 ไว้
เสี่ยง contaminated

แปรง SUD แพง



	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การล้างมือเพื่อส่งเครื่องมือผ่าตัด	หน้า : 1 / 4 รหัสเอกสาร : NS-04-3-003-03 ทบทวนครั้งที่ : 3 เมษายน 2566 วันที่อนุมัติ : 3 เมษายน 2569
ชื่อหน่วยงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด		วันที่หมดอายุ : 3 เมษายน 2569
ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด		ผู้อนุมัติ : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ

วิธีล้างมือ	ขั้นตอนการปฏิบัติ
	3. กดน้ำยาอีก 1 ครั้ง ถูบริเวณมือทั้งสองข้างไปจนถึงข้อมืออีกครั้ง 4. ปล่อยมือทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ดออก หมายเหตุ กรณีสำหรับการส่งเครื่องมือผ่าตัดครั้งแรกของวัน ให้ล้างมือแบบใช้แปรง หลังจากนั้นสามารถล้างมือแบบไม่ใช้แปรงได้¹
3. แบบไม่ใช้แปรง โดยใช้ น้ำยา Alcohol – based hand rub ดังนี้ (ภาพที่ 4)¹	1. กดน้ำยา Alcohol – based hand rub 1 ครั้ง (2 มิลลิลิตร) ลงบนฝ่ามือข้างหนึ่ง จุ่มปลายนิ้วมืออีกข้างลงบนน้ำยาแล้วทำความสะอาดบริเวณซอกเล็บนาน 5 วินาที จากนั้นเกลี่ยน้ำยาที่เหลือไปบนหลังมือ และถูไล่ลงไปถึงข้อศอก

6. เอกสารอ้างอิง

1. Association of Perioperative Registered Nurse. The Guideline for Hand Hygiene 5 new Hand Hygiene Practices to Reduce Infection. AORN e-guidelines [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 28]. Available from <https://www.aorn.org/about-aorn/aorn-newsroom/periop-today-newsletter/2022/2022-articles/new-hand-hygiene-practices>

Guideline Quick View: Hand Hygiene

<http://doi.org/10.1002/aorn.13783>
© AORN, Inc, 2022.



FINGERNAIL AND SKIN CONDITION

- Maintain healthy, natural fingernails that are no longer than 2 mm (0.08 inches).

- Do not wear artificial fingernails or extenders.
- Do not wear lacquer (ie, nail polish) or enhanced nail lacquer (eg, ultraviolet cured [gel], dipped nail coating) while performing the scrub role.
- Follow facility policy and procedures on the use of nail lacquer or enhanced nail lacquer products for non-scrubbed roles.
- Take measures to prevent hand dermatitis, including:
 - using moisturizing skin care products that are approved by the health care organization and compatible with hand hygiene and surgical hand antisepsis products
 - implementing practices that decrease skin irritation (eg, controlling water temperature, completely drying hands before donning gloves)
 - selecting less irritating hand hygiene products (eg, an alcohol-based hand rub instead of soap)
 - participating in education on hand dermatitis prevention

★ Perioperative team members with breaks in skin integrity or infections of the nails, hands, or arms may be at risk for acquiring infections or transmitting pathogens to patients. Perioperative team members should restrict patient care activities if dermatitis, infection, exudative lesions, or non-intact skin of the hands or arms is present.



★ *Surgical hand antisepsis is the primary line of defense to protect patients from pathogens on the hands of perioperative team members. High-quality evidence indicates that the surgical hand rub and surgical hand scrub are equally effective in reducing bacterial counts on the hands of health care professionals.*



SURGICAL HAND SCRUB

- Perform a surgical hand scrub according to the manufacturer's IFU.
- Remove all jewelry from the hands and wrists.
- Don a surgical mask.
- Wash hands with soap and water if visibly soiled.
- Remove debris from underneath fingernails using a disposable nail cleaner under running water. ★
- Thoroughly dry hands and arms with a disposable paper towel.
- Apply the amount of surgical hand scrub product per the manufacturer's IFU to the hands and forearms using a soft, nonabrasive sponge.
- Visualize each finger, hand, and arm as having four sides and wash all four sides effectively, keeping the hands elevated. / **อย่างน้อย 3-5 นาที**
- Scrub for the length of time recommended in the manufacturer's IFU by timing the contact of the scrub product with the skin.
- Rinse hands and arms under running water in one direction, from fingertips to elbows.
- Hold hands higher than elbows and away from surgical attire.
- In the OR or procedure room, dry hands and arms with a sterile towel using sterile technique before donning a surgical gown and gloves.

2) ออกแบบนวัตกรรม



เปรียบเทียบขั้นตอนการล้างมือเพื่อส่งเครื่องมือผ่าตัด

แบบที่ 1 (แบบเดิม)	แบบที่ 2 (แบบใหม่ ใช้ 1 แปร)	แบบที่ 3 (ไม่ใช้แปร)
การล้างมือเพื่อส่งผ่าตัด: NS-04-3-003-03	Apply from Guideline Quick view: Hand Hygiene	Apply from Guideline Quick view: Hand Hygiene
2 แปร ล้าง 3 ครั้ง และเวลา <u>รวม 6-9 นาที</u> ไม่ระบุปริมาณน้ำยา	1 แปร ล้าง 2 ครั้ง และ <u>เวลา 3 นาที</u> ปริมาณน้ำยา <u>3-5 มล./ครั้ง</u>	ล้าง 2 ครั้ง และ <u>เวลา 3 นาที 20 วินาที</u> ปริมาณน้ำยา <u>3-5 มล./ครั้ง</u>
ดูแลมือและเล็บให้สะอาดเรียบร้อย ถอดเครื่องประดับบริเวณมือและข้อมือออกทั้งหมด (ใส่ surgical mask)	ดูแลมือและเล็บให้สะอาดเรียบร้อย ถอดเครื่องประดับบริเวณมือและข้อมือออกทั้งหมด ใส่ surgical mask	ดูแลมือและเล็บให้สะอาดเรียบร้อย ถอดเครื่องประดับบริเวณมือและข้อมือออกทั้งหมด ใส่ surgical mask
ล้างมือแบบ Hygienic hand washing อย่างน้อย 30 วินาที	ล้างมือแบบ Hygienic hand washing อย่างน้อย 30 วินาที ฟอกมือและแขนจนถึงข้อศอกด้วยสบู่ผสมน้ำยาทำลายเชื้อ 4% chlorhexidine gluconate หรือ 7.5% iodophor	ล้างมือแบบ Hygienic hand washing อย่างน้อย 30 วินาที ฟอกมือและแขนจนถึงข้อศอกด้วยสบู่ผสมน้ำยาทำลายเชื้อ 4% chlorhexidine gluconate หรือ 7.5% iodophor
1. เริ่มแปรอันที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยใช้มือเปิดแปรออกจากห่อปราศจากเชื้อจำนวน 2 ห่อ โดยวางไว้ใกล้อ่างล้างมือ	การทำความสะอาดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่ มือทั้ง 2 ข้าง และแขนทั้ง 2 ข้าง ปฏิบัติดังนี้ 1. เปิดปากห่อแปรปราศจากเชื้อ หยิบแปรออกจากห่อ	การทำความสะอาดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่ มือทั้ง 2 ข้าง และแขนทั้ง 2 ข้าง ปฏิบัติดังนี้
2. หยิบแปร ใช้ข้อศอกกดน้ำยาทำลายเชื้อและน้ำลงบนแปรเล็กน้อย เริ่มแปรตั้งแต่ปลายนิ้ว วนรอบนิ้วแต่ละนิ้ว ซอกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือ ข้อมือ จนถึงเหนือข้อศอกขึ้นไป 2 นิ้ว เติมน้ำและน้ำยาอีกเล็กน้อย แปรมืออีกข้างเช่นเดียวกัน	2. <u>แปรครั้งที่ 1</u> กดน้ำยา 4% chlorhexidine gluconate 5 มล. และน้ำลงบนแปรด้านขนแปร เริ่มแปรตั้งแต่ปลายนิ้ว และซอกเล็บ วนรอบนิ้วแต่ละนิ้ว ซอกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาข้างละอย่างน้อย 30 วินาที	1. กดสบู่ผสมน้ำยา 4% chlorhexidine gluconate 3 มล. ลงบนฝ่ามือ จุ่มปลายนิ้วมืออีกข้างลงบนน้ำยา นาน 5 วินาที จากนั้นกดสบู่ผสมน้ำยา 4% chlorhexidine gluconate 3 มล. ลงบนฝ่ามืออีกด้าน จุ่มปลายนิ้วมืออีกข้างลงบนน้ำยา นาน 5 วินาที
3. แปรถูกวนเป็นวงกลมต่อเนื่องกัน ใช้เวลาในการแปร 2 - 3 นาที เมื่อแปรมือและแขน ทั้ง 2 ข้างเสร็จแล้วล้างแปร มือ และแขนทั้ง 2 ข้างให้สะอาดโดยวิธีให้น้ำไหลผ่านจากมือถึงข้อศอก ยกมือให้สูงกว่าข้อศอกตลอดเวลา	3. เติมน้ำและน้ำยา 4% chlorhexidine gluconate 3 มล. วนเป็นวงกลมต่อเนื่องกันจากข้อมือจนถึงเหนือข้อศอกขึ้นไป 2 นิ้ว อาจใช้ด้านพองน้ำได้เพื่อป้องกันผิวหนังถูกรูด แปรอีกข้างเช่นเดียวกัน ใช้เวลาข้างละอย่างน้อย 15 วินาที	2. กดน้ำลงฝ่ามือเล็กน้อย เริ่มถูมือตั้งแต่ปลายนิ้ว และซอกเล็บ วนรอบนิ้วแต่ละนิ้ว ซอกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาข้างละอย่างน้อย 30 วินาที

3) ทดลองใช้



การทดสอบ Surgical hand washing

ขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้

- 1) อาสาสมัครลงชื่อทดสอบที่หัวหน้าหน่วย
- 2) จับของสุ่มวิธีการล้างมือ 3 แบบ อ่านทำความเข้าใจในขั้นตอนการล้างมือตามแบบที่จับของได้
- 3) ทา magic cream **2 cc.** ลงบนฝ่ามือ จากนั้นถู magic cream ให้ทั่วฝ่ามือ และหลังมือถึงข้อมือ

แบบ หน้า-หลัง-ปั้น-โป้ง-ปลาย-ข้อ

- 4) นำมือทั้งสองข้างส่องเครื่อง UV light เพื่อตรวจสอบการทำ magic cream
- 5) ล้างมือตามแบบที่จับของได้
- 5) ประเมินประสิทธิภาพการล้างมือด้วยเครื่อง UV light โดยผู้ประเมินตรวจสอบการคงเหลือของ magic cream
- 6) ผู้ประเมินบันทึก magic cream ที่ตกค้างบน diagram ในใบ case record form
- 7) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Z

กำหนดตัวชี้วัด

อัตราบุคลากรทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ หมายถึง ภายหลังจากการทำความสะอาดมือแล้วไม่พบ Magic cream บนมือทั้งหมด 52 จุด



Case record form Effective Surgical hand washing Project		Code
		Date
ผู้ประเมิน: เขียนเครื่องหมาย วงกลม บริเวณที่พบ magic cream		
		สำหรับผู้วิเคราะห์ข้อมูล Total 26 Area ฝ่ามือ 13 area พบ area หลังมือ 13 area พบ area
		สำหรับผู้วิเคราะห์ข้อมูล Total 26 Area ฝ่ามือ 13 area พบ area หลังมือ 13 area พบ area



การทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือแบบ **Surgical** hand washing

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. อัตราบุคลากรทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ หมายถึง ภายหลังจากการทำความสะอาดมือแล้วไม่พบ Magic cream บนมือทั้งหมด 52 จุด		
แบบที่ 1 ใช้แปร่ง 2 แปร่ง แปร่ง 3 ครั้ง ทำความสะอาดใช้เวลา 6-9 นาที	100%	53%
แบบที่ 2 ใช้ 1 แปร่ง แปร่ง 2 ครั้ง ทำความสะอาดใช้เวลา 3 นาที	100%	43.3%
แบบที่ 3 ไม่ใช้แปร่ง ทำความสะอาดใช้เวลา 3 นาที 20 วินาที	100%	0%

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing 3 แบบ

วิธีการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing	จำนวนบุคลากรที่พบ Magic cream หลังการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing (จำนวนกลุ่มละ 30 ราย)			
	ไม่พบเลย	พบ 1 จุด	พบ 2 จุด	พบ ≥ 3 จุด
แบบที่ 1 ใช้แปร่ง 2 แปร่ง แปร่ง 3 ครั้ง ทำความสะอาดใช้เวลา 6-9 นาที	16 ราย 53.3%	6 ราย 20%	2 ราย 6.6%	6 ราย 20%
แบบที่ 2 ใช้ 1 แปร่ง แปร่ง 2 ครั้ง ทำความสะอาดใช้เวลา 3 นาที	13 ราย 43.3%	4 ราย 13.3%	1 ราย 3.3%	12 ราย 40%
แบบที่ 3 ไม่ใช้แปร่ง ทำความสะอาดใช้เวลา 3 นาที 20 วินาที	0 0%	0 0%	4 ราย 13.3%	26 ราย 86.6%

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing แบบที่ 1 และ 2

Frequencies		
	gr	N
Agg	1	30
	2	30
	Total	60

Test Statistics ^a		
		Agg
Most Extreme Differences	Absolute	.267
	Positive	.267
	Negative	.000
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.236

a. Grouping Variable: gr

จากตารางที่ 4 Test Statistics ค่า Kolmogorov – Smirnov Z เท่ากับ 1.033 และค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ .236 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ $\alpha = .05$ นั่นคือ > 0.05 ยอมรับ H_0 แสดงว่า การแจกแจงข้อมูลกลุ่ม 1 และ 2 เหมือนกัน

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing แบบที่ 1 และ 3

Frequencies

	gr	N
Agg	1	30
	3	30
	Total	60

Test Statistics^a

		Agg
Most Extreme Differences	Absolute	.600
	Positive	.600
	Negative	.000
Kolmogorov-Smirnov Z		2.324
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Grouping Variable: gr

จากตารางที่ 5 Test Statistics ค่า Kolmogorov – Smirnov Z เท่ากับ 2.324 และค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ $\alpha = .05$ นั่นคือ < 0.05 ปฏิเสธ H_0 (ยอมรับ H_1) แสดงว่า การแจกแจงข้อมูลกลุ่ม 1 และ 3 แตกต่างกัน

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างการทำความสะอาดมือแบบ Surgical hand washing แบบที่ 2 และ 3

Frequencies

	gr	N
Agg	2	30
	3	30
	Total	60

Test Statistics^a

	Agg
Most Extreme Differences	Absolute .467
	Positive .467
	Negative .000
Kolmogorov-Smirnov Z	1.807
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003

a. Grouping Variable: gr

จากตารางที่ 6 Test Statistics ค่า Kolmogorov – Smirnov Z เท่ากับ 1.807 และค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ $\alpha = .05$ นั่นคือ < 0.05 ปฏิเสธ H_0 (ยอมรับ H_1) แสดงว่า การแจกแจงข้อมูลกลุ่ม 2 และ 3 แตกต่างกัน

4) ขยายผล



แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
Apply from Guideline Quick view: Hand Hygiene	Apply from Guideline Quick view: Hand Hygiene	การทำความสะอาดมือ: SI-11-2-017-04
ใช้ 1 แปรอง แปรอง 2 ครั้ง ร่วมกับสบู่ผสม น้ำยาทำลายเชื้อ 4% chlorhexidine gluconate หรือ 7.5% iodophor ครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร รวม 18-20 มิลลิลิตร *ต้องใช้แปรองในรายแรกของวัน	ไม่ใช้แปรอง ใช้สบู่ผสมน้ำยาทำลายเชื้อ 4% chlorhexidine gluconate หรือ 7.5% iodophor ครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร รวม 18-20 มิลลิลิตร	ใช้ Alcohol base rub น้ำยา 1% chlorhexidine in 60% ethyl alcohol ครั้งละ 5 มิลลิลิตร รวม 15 มิลลิลิตร
ใช้เวลา 3 นาที	ใช้เวลา 3 นาที 20 วินาที	ใช้เวลา 1 นาที 30 วินาที หรือจนแห้ง



วิจัยทางการแพทย์

Needs of relatives during elective surgery

The effect of giving informational and emotional support on anxiety of relatives during surgery

(Wanvimol Kongsuwan)

ศึกษาความต้องการขณะรอผ่าตัดของญาติผู้ป่วยอุบัติเหตุที่
ได้รับการผ่าตัดสมอง ณ หน่วยผ่าตัดอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลศิริราช

(วรลักษณ์ บุญชัย)



วิจัยทางการแพทย์พยาบาล

อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ำของผู้ป่วยขณะผ่าตัด, 2558

(วรรณวิมล คงสุวรรณ และลลิตา จ่านงค์เลิศ)

Result

6 Factors related hypothermia are age, BMI, body temperature before surgery, warming device, Irrigation, and type of surgery

อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น, 2559

(ญาณันท์ รัตนธีรวิเชียร)

การศึกษาผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำของผู้ป่วยผ่าตัดต่อม
ลูกหมากผ่านทางกล้อง หนวยผ่าตัดระบบปั๊สสภาวะ
โรงพยาบาลศิริราช, 2564

(กุลวรา คุปรัตน์ และคณะ)



วิจัยทางการพยาบาล

การศึกษาผลของรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจสอบกล้องทางจุมก
ระหว่างการพ่นยา 3 % ephedrine และ 4 % lidocaine อย่างละ 2 ครั้ง
เปรียบเทียบกับ การพ่นยา 3 % ephedrine และ 4 % lidocaine ตามด้วย
การใส่ยาชาจุมกด้วย cotton bud, 2554

(นงศ์เยาว์ นุชนารถ และ คณะ)

ผลของโปรแกรมการจัดการก๊าชในช่องท้องขณะผ่าตัดต่อการแน่นท้องและ
การปวดไหล่หลังผ่าตัดในผู้ป่วย LC, 2560

(วิศรา ตวยานนท์ และ คณะ)

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการตัดสายเลเซอร์โดยใช้อุปกรณ์จับสาย
เลเซอร์กับ ceramic scissors และ cleaving pen, 2565

(ญาณันท์ รัตนธีรวิเชียร และคณะ)

โครงการพัฒนาคุณภาพในห้องผ่าตัด



การเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ ??



การเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

เพื่อสะท้อน

- การวางแผนอย่างเป็นระบบ
- มีกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- บรรลุเป้าหมาย (...จริงรึป่าว?)



ขั้นตอนการทำโครงการพัฒนาคุณภาพ



- 1) **จะทำอะไร** : ชื่อโครงการต้องชัด ชิงบวก
- 2) **ทำไมจึงต้องทำ** : ที่มา (หลักการและเหตุผล) ต้องมีข้อมูลประกอบใช้เป็นผล
ก่อนทำโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับหลังทำโครงการ
- 3) **ทำเพื่ออะไร** : วัตถุประสงค์
- 4) **ทำอะไร** : แผน/ ขั้นตอนการดำเนินการ
- 5) **จะทำเมื่อไร** : ระยะเวลาการดำเนินการ Timeframe
- 6) **ต้องใช้เงินและทรัพยากรอะไรบ้างและเท่าไร** : resources
- 7) **ใครเป็นผู้รับผิดชอบ** : หัวหน้าโครงการ สมาชิกในทีม
process owner & supporter & information provider
- 8) **จะทราบผลการดำเนินงานได้อย่างไร** : แผน และผลลัพธ์ตัวชี้วัด
- 9) **มีผลกระทบ/ ประโยชน์ได้อะไรบ้าง**

Gantt chart



หัวข้อการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

- 1) ชื่อโครงการ
- 2) รายชื่อผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ, สมาชิกโครงการ)
- 3) ที่มาของโครงการ
 - ปัญหาที่เกิดขึ้น, สถิติ, อ้างอิง/ สาเหตุของปัญหา
 - วิธีการจัดการ (สิ่งที่คิดว่าจะทำ)
- 4) วัตถุประสงค์
- 5) แนวคิด/ ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้
- 6) ทรัพยากรที่ใช้/ งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)
- 7) ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดพอสังเขป)
 - อธิบายตาม PDCA
 - อธิบายด้วย Gantt chart
- 7.1) ระยะเวลาดำเนินการ
- 7.2) ขั้นตอนการประดิษฐ์ และการใช้งาน (Product)
- 8) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ *ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- 9) การพัฒนาปรับปรุง
- 10) สรุปผลการดำเนินการ
 - 10.1) ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
 - 10.2) กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
- 11) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนำเสนอโครงการ



การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ

โครงการพัฒนากระบวนการงาน

ชื่อโครงการ :

ที่มา :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดโครงการ :

ตอบสนองตัวชี้วัดของหน่วยงาน :

งบประมาณ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้รับผิดชอบ : (กรณีมีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ให้ระบุเป็น % ความรับผิดชอบ)

ขั้นตอน/กิจกรรม ดำเนินการ	ปี 2563			ปี 2564									ผู้รับผิดชอบหลัก
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

หมายเหตุ : $\longleftrightarrow$, ● หมายถึง ระยะเวลาวางแผนดำเนินการ

$\longleftrightarrow$, วันที่ หมายถึง การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง



Gantt Chart

ขั้นตอน/กิจกรรม ดำเนินการ		ปี 2563			ปี 2564								ผู้รับผิดชอบหลัก	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. A	แผน													
	ผล													
2. B	แผน													
	ผล													
3. C	แผน													
	ผล													

- หมายเหตุ :
- , ● หมายถึง ระยะเวลาวางแผนดำเนินการ
 - , วันที่ หมายถึง การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง
 - เป็นไปตามแผน ส่งผลลัพธ์การทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด
 - กำลังดำเนินการ
 - ไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

**ตรวจงาน CQI
ยังไง ?**

ให้คำแนะนำยังไง ?



ปัญหาและที่มาของโครงการ

- 1) เนื้อหาทั้งหมดเรียบเรียงอย่างไร? Narrow down ?
- 2) ปัญหาหลัก / Pain point อยู่ที่ไหน ??
- 3) ข้อมูลทางสถิติ และการอ้างอิง ?
- 4) การใช้ภาษาเขียน: ความซ้ำซ้อน น่าเยอะ ใช้ภาษาพูด ใช้ความรู้สึก ??
- 5) เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงพยาบาล/ฝ่ายการพยาบาล/ มาตรฐาน/หน่วยงาน

6) ปัญหาที่กล่าวมา เทียบกับ วัตถุประสงค์ เทียบกับ ตัวชี้วัดไปทิศทางเดียวกันหรือไม่ ? การออกแบบเก็บข้อมูลอย่างไร ตอนไหน ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บข้อมูล ?

- 7) ขั้นตอนการประดิษฐ์อธิบายได้ครบถ้วน เห็นภาพชัดเจนหรือไม่ ?
- 8) วัสดุที่ใช้ในร่างกาย/ operative filed ได้มาตรฐานหรือไม่ ? ผู้ป่วยจะปลอดภัยหรือไม่ ?
- 9) ทรพยากร-ขั้นตอนการประดิษฐ์-การใช้งานสอดคล้องกันหรือไม่ ?
- 10) ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุกิจกรรมและ Timeline
กรณีที่มีหลายกิจกรรมมาก อาจแบ่งเป็นระยะ (phase) และอธิบายกิจกรรมแต่ละ phase ได้
- 11) ขั้นตอนการนำไปใช้ ระบุเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ให้เห็นภาพชัดเจน
- 12) การดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นมาตรฐานการทำงานจริงป่าว?
- 13) มีการขยายผลใช้ภายใน ภายนอกองค์กรไหม?
- 14) อื่นๆ
 - ตำแหน่งการถ่ายภาพประกอบ การใส่เลขภาพ และการเขียนอ้างอิงใต้ภาพ ถูกต้องไหม?
 - การเขียนเอกสารอ้างอิงถูกต้องไหม?



เกณฑ์การให้
คะแนนของเขา
มีอะไรบ้าง ?



no.	หัวข้อการให้คะแนน 1-5 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)	คะแนนเต็ม
1	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	25
2	ประสิทธิผล (บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)	15
3	ประสิทธิภาพ (ความคุ้มค่า คำนวณ)	15
4	ความปลอดภัย มีการอ้างอิงงานวิจัย หลักฐานเชิง ประจักษ์ต่างๆ	25
5	การใช้ประโยชน์	15
6	ความครบถ้วนของเนื้อหาตามที่กำหนด 9 ข้อ	5

อุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ

3 wall PI protector



ที่มาของโครงการ

ในปี พ.ศ.2564 พบอุบัติการณ์เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยระยะผ่าตัดที่บริเวณกระดูกข้อเท้าและสันเท้าจำนวน 3 รายอุบัติการณ์ทั้งหมดเกิดกับผู้ป่วยเด็กอายุ 1-5 ปีที่มี Operation time มากกว่า 2 ชั่วโมง Under General anesthesia จากการวิเคราะห์และสังเกตพบเท้าทั้งสองข้างของเด็กเกิดแผลและออกด้านข้างขณะดมยาจนทำให้ผิวหนังบริเวณกระดูกสันหลังเกิดการเกิดแผลกดทับได้มากกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ 3 wall PI Protector เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณกระดูกข้อเท้าและสันเท้าทั้งสามด้านคือด้านนอกด้านในและสันเท้า อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ สอดคล้องและตอบสนองนโยบายขององค์กรที่ประกาศเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณสันเท้าและกระดูกข้อเท้าทั้งด้านนอกและด้านใน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ป่วยเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี ที่ได้รับการผ่าตัดทางจักษุ
2. ผู้ป่วยระยะรับความรู้สึกด้วยวิธี General anesthesia (GA)
3. ผู้ป่วยเด็กที่มีระยะเวลาในการผ่าตัด (Operation time) เท่ากับหรือมากกว่า 2 ชั่วโมง

เจ้าของผลงาน นางนพวรรณ สิทธิสาร
สังกัด หน่วยผ่าตัดจักษุ งานการพยาบาลผ่าตัด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล



ภาพแสดงแผลกดทับที่สันเท้าในผู้ป่วยเด็ก

ภาพแสดงลักษณะเท้าที่แตกต่างกันของผู้ป่วยเด็กขณะดมยา

อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ผ้าฝ้าย 100 % 2. ผ้าซาติน 3. โปलिएสเตอร์ (polyester)
4. ด้าย เข็ม กรรไกร ไบรพัต ดินสอ 5. กระดาษออกแบบ 6. เมจิกเทป (ตีนตุ๊กแก)
7. ยางยืดขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร





Perioperative Nursing Care Conference 5th 2011
"Safety Management in Operating Room"
9-10 July 2011

นวัตกรรม ผ้าซับโหนดจี้

นางนพวรรณ สิทธิสาร และ ดร.พรพจน์ คงฤกษ์
"มูลนิธิสุขภาพไทย"
"งานประชุมวิชาการระดับ
ประเทศด้านนวัตกรรม นวัตกรรมศิริราช" 10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221-223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-243-245-247-249-251-253-255-257-259-261-263-265-267-269-271-273-275-277-279-281-283-285-287-289-291-293-295-297-299-301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-329-331-333-335-337-339-341-343-345-347-349-351-353-355-357-359-361-363-365-367-369-371-373-375-377-379-381-383-385-387-389-391-393-395-397-399-401-403-405-407-409-411-413-415-417-419-421-423-425-427-429-431-433-435-437-439-441-443-445-447-449-451-453-455-457-459-461-463-465-467-469-471-473-475-477-479-481-483-485-487-489-491-493-495-497-499-501-503-505-507-509-511-513-515-517-519-521-523-525-527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-579-581-583-585-587-589-591-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611-613-615-617-619-621-623-625-627-629-631-633-635-637-639-641-643-645-647-649-651-653-655-657-659-661-663-665-667-669-671-673-675-677-679-681-683-685-687-689-691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749-751-753-755-757-759-761-763-765-767-769-771-773-775-777-779-781-783-785-787-789-791-793-795-797-799-801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999-1001-1003-1005-1007-1009-1011-1013-1015-1017-1019-1021-1023-1025-1027-1029-1031-1033-1035-1037-1039-1041-1043-1045-1047-1049-1051-1053-1055-1057-1059-1061-1063-1065-1067-1069-1071-1073-1075-1077-1079-1081-1083-1085-1087-1089-1091-1093-1095-1097-1099-1101-1103-1105-1107-1109-1111-1113-1115-1117-1119-1121-1123-1125-1127-1129-1131-1133-1135-1137-1139-1141-1143-1145-1147-1149-1151-1153-1155-1157-1159-1161-1163-1165-1167-1169-1171-1173-1175-1177-1179-1181-1183-1185-1187-1189-1191-1193-1195-1197-1199-1201-1203-1205-1207-1209-1211-1213-1215-1217-1219-1221-1223-1225-1227-1229-1231-1233-1235-1237-1239-1241-1243-1245-1247-1249-1251-1253-1255-1257-1259-1261-1263-1265-1267-1269-1271-1273-1275-1277-1279-1281-1283-1285-1287-1289-1291-1293-1295-1297-1299-1301-1303-1305-1307-1309-1311-1313-1315-1317-1319-1321-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1337-1339-1341-1343-1345-1347-1349-1351-1353-1355-1357-1359-1361-1363-1365-1367-1369-1371-1373-1375-1377-1379-1381-1383-1385-1387-1389-1391-1393-1395-1397-1399-1401-1403-1405-1407-1409-1411-1413-1415-1417-1419-1421-1423-1425-1427-1429-1431-1433-1435-1437-1439-1441-1443-1445-1447-1449-1451-1453-1455-1457-1459-1461-1463-1465-1467-1469-1471-1473-1475-1477-1479-1481-1483-1485-1487-1489-1491-1493-1495-1497-1499-1501-1503-1505-1507-1509-1511-1513-1515-1517-1519-1521-1523-1525-1527-1529-1531-1533-1535-1537-1539-1541-1543-1545-1547-1549-1551-1553-1555-1557-1559-1561-1563-1565-1567-1569-1571-1573-1575-1577-1579-1581-1583-1585-1587-1589-1591-1593-1595-1597-1599-1601-1603-1605-1607-1609-1611-1613-1615-1617-1619-1621-1623-1625-1627-1629-1631-1633-1635-1637-1639-1641-1643-1645-1647-1649-1651-1653-1655-1657-1659-1661-1663-1665-1667-1669-1671-1673-1675-1677-1679-1681-1683-1685-1687-1689-1691-1693-1695-1697-1699-1701-1703-1705-1707-1709-1711-1713-1715-1717-1719-1721-1723-1725-1727-1729-1731-1733-1735-1737-1739-1741-1743-1745-1747-1749-1751-1753-1755-1757-1759-1761-1763-1765-1767-1769-1771-1773-1775-1777-1779-1781-1783-1785-1787-1789-1791-1793-1795-1797-1799-1801-1803-1805-1807-1809-1811-1813-1815-1817-1819-1821-1823-1825-1827-1829-1831-1833-1835-1837-1839-1841-1843-1845-1847-1849-1851-1853-1855-1857-1859-1861-1863-1865-1867-1869-1871-1873-1875-1877-1879-1881-1883-1885-1887-1889-1891-1893-1895-1897-1899-1901-1903-1905-1907-1909-1911-1913-1915-1917-1919-1921-1923-1925-1927-1929-1931-1933-1935-1937-1939-1941-1943-1945-1947-1949-1951-1953-1955-1957-1959-1961-1963-1965-1967-1969-1971-1973-1975-1977-1979-1981-1983-1985-1987-1989-1991-1993-1995-1997-1999-2001-2003-2005-2007-2009-2011-2013-2015-2017-2019-2021-2023-2025-2027-2029-2031-2033-2035-2037-2039-2041-2043-2045-2047-2049-2051-2053-2055-2057-2059-2061-2063-2065-2067-2069-2071-2073-2075-2077-2079-2081-2083-2085-2087-2089-2091-2093-2095-2097-2099-2101-2103-2105-2107-2109-2111-2113-2115-2117-2119-2121-2123-2125-2127-2129-2131-2133-2135-2137-2139-2141-2143-2145-2147-2149-2151-2153-2155-2157-2159-2161-2163-2165-2167-2169-2171-2173-2175-2177-2179-2181-2183-2185-2187-2189-2191-2193-2195-2197-2199-2201-2203-2205-2207-2209-2211-2213-2215-2217-2219-2221-2223-2225-2227-2229-2231-2233-2235-2237-2239-2241-2243-2245-2247-2249-2251-2253-2255-2257-2259-2261-2263-2265-2267-2269-2271-2273-2275-2277-2279-2281-2283-2285-2287-2289-2291-2293-2295-2297-2299-2301-2303-2305-2307-2309-2311-2313-2315-2317-2319-2321-2323-2325-2327-2329-2331-2333-2335-2337-2339-2341-2343-2345-2347-2349-2351-2353-2355-2357-2359-2361-2363-2365-2367-2369-2371-2373-2375-2377-2379-2381-2383-2385-2387-2389-2391-2393-2395-2397-2399-2401-2403-2405-2407-2409-2411-2413-2415-2417-2419-2421-2423-2425-2427-2429-2431-2433-2435-2437-2439-2441-2443-2445-2447-2449-2451-2453-2455-2457-2459-2461-2463-2465-2467-2469-2471-2473-2475-2477-2479-2481-2483-2485-2487-2489-2491-2493-2495-2497-2499-2501-2503-2505-2507-2509-2511-2513-2515-2517-2519-2521-2523-2525-2527-2529-2531-2533-2535-2537-2539-2541-2543-2545-2547-2549-2551-2553-2555-2557-2559-2561-2563-2565-2567-2569-2571-2573-2575-2577-2579-2581-2583-2585-2587-2589-2591-2593-2595-2597-2599-2601-2603-2605-2607-2609-2611-2613-2615-2617-2619-2621-2623-2625-2627-2629-2631-2633-2635-2637-2639-2641-2643-2645-2647-2649-2651-2653-2655-2657-2659-2661-2663-2665-2667-2669-2671-2673-2675-2677-2679-2681-2683-2685-2687-2689-2691-2693-2695-2697-2699-2701-2703-2705-2707-2709-2711-2713-2715-2717-2719-2721-2723-2725-2727-2729-2731-2733-2735-2737-2739-2741-2743-2745-2747-2749-2751-2753-2755-2757-2759-2761-2763-2765-2767-2769-2771-2773-2775-2777-2779-2781-2783-2785-2787-2789-2791-2793-2795-2797-2799-2801-2803-2805-2807-2809-2811-2813-2815-2817-2819-2821-2823-2825-2827-2829-2831-2833-2835-2837-2839-2841-2843-2845-2847-2849-2851-2853-2855-2857-2859-2861-2863-2865-2867-2869-2871-2873-2875-2877-2879-2881-2883-2885-2887-2889-2891-2893-2895-2897-2899-2901-2903-2905-2907-2909-2911-2913-2915-2917-2919-2921-2923-2925-2927-2929-2931-2933-2935-2937-2939-2941-2943-2945-2947-2949-2951-2953-2955-2957-2959-2961-2963-2965-2967-2969-2971-2973-2975-2977-2979-2981-2983-2985-2987-2989-2991-2993-2995-2997-2999-3001-3003-3005-3007-3009-3011-3013-3015-3017-3019-3021-3023-3025-3027-3029-3031-3033-3035-3037-3039-3041-3043-3045-3047-3049-3051-3053-3055-3057-3059-3061-3063-3065-3067-3069-3071-3073-3075-3077-3079-3081-3083-3085-3087-3089-3091-3093-3095-3097-3099-3101-3103-3105-3107-3109-3111-3113-3115-3117-3119-3121-3123-3125-3127-3129-3131-3133-3135-3137-3139-3141-3143-3145-3147-3149-3151-3153-3155-3157-3159-3161-3163-3165-3167-3169-3171-3173-3175-3177-3179-3181-3183-3185-3187-3189-3191-3193-3195-3197-3199-3201-3203-3205-3207-3209-3211-3213-3215-3217-3219-3221-3223-3225-3227-3229-3231-3233-3235-3237-3239-3241-3243-3245-3247-3249-3251-3253-3255-3257-3259-3261-3263-3265-3267-3269-3271-3273-3275-3277-3279-3281-3283-3285-3287-3289-3291-3293-3295-3297-3299-3301-3303-3305-3307-3309-3311-3313-3315-3317-3319-3321-3323-3325-3327-3329-3331-3333-3335-3337-3339-3341-3343-3345-3347-3349-3351-3353-3355-3357-3359-3361-3363-3365-3367-3369-3371-3373-3375-3377-3379-3381-3383-3385-3387-3389-3391-3393-3395-3397-3399-3401-3403-3405-3407-3409-3411-3413-3415-3417-3419-3421-3423-3425-3427-3429-3431-3433-3435-3437-3439-3441-3443-3445-3447-3449-3451-3453-3455-3457-3459-3461-3463-3465-3467-3469-3471-3473-3475-3477-3479-3481-3483-3485-3487-3489-3491-3493-3495-3497-3499-3501-3503-3505-3507-3509-3511-3513-3515-3517-3519-3521-3523-3525-3527-3529-3531-3533-3535-3537-3539-3541-3543-3545-3547-3549-3551-3553-3555-3557-3559-3561-3563-3565-3567-3569-3571-3573-3575-3577-3579-3581-3583-3585-3587-3589-3591-3593-3595-3597-3599-3601-3603-3605-3607-3609-3611-3613-3615-3617-3619-3621-3623-3625-3627-3629-3631-3633-3635-3637-3639-3641-3643-3645-3647-3649-3651-3653-3655-3657-3659-3661-3663-3665-3667-3669-3671-3673-3675-3677-3679-3681-3683-3685-3687-3689-3691-3693-3695-3697-3699-3701-3703-3705-3707-3709-3711-3713-3715-3717-3719-3721-3723-3725-3727-3729-3731-3733-3735-3737-3739-3741-3743-3745-3747-3749-3751-3753-3755-3757-3759-3761-3763-3765-3767-3769-3771-3773-3775-3777-3779-3781-3783-3785-3787-3789-3791-3793-3795-3797-3799-3801-3803-3805-3807-3809-3811-3813-3815-3817-3819-3821-3823-3825-3827-3829-3831-3833-3835-3837-3839-3841-3843-3845-3847-3849-3851-3853-3855-3857-3859-3861-3863-3865-3867-3869-3871-3873-3875-3877-3879-3881-3883-3885-3887-3889-3891-3893-3895-3897-3899-3901-3903-3905-3907-3909-3911-3913-3915-3917-3919-3921-3923-3925-3927-3929-3931-3933-3935-3937-3939-3941-3943-3945-3947-3949-3951-3953-3955-3957-3959-3961-3963-3965-3967-3969-3971-3973-3975-3977-3979-3981-3983-3985-3987-3989-3991-3993-3995-3997-3999-4001-4003-4005-4007-4009-4011-4013-4015-4017-4019-4021-4023-4025-4027-4029-4031-4033-4035-4037-4039-4041-4043-4045-4047-4049-4051-4053-4055-4057-4059-4061-4063-4065-4067-4069-4071-4073-4075-4077-4079-4081-4083-4085-4087-4089-4091-4093-4095-4097-4099-4101-4103-4105-4107-4109-4111-4113-4115-4117-4119-4121-4123-4125-4127-4129-4131-4133-4135-4137-4139-4141-4143-4145-4147-4149-4151-4153-4155-4157-4159-4161-4163-4165-4167-4169-4171-4173-4175-4177-4179-4181-4183-4185-4187-4189-4191-4193-4195-4197-4199-4201-4203-4205-4207-4209-4211-4213-4215-4217-4219-4221-4223-4225-4227-4229-4231-4233-4235-4237-4239-4241-4243-4245-4247-4249-4251-4253-4255-4257-4259-4261-4263-4265-4267-4269-4271-4273-4275-4277-4279-4281-4283-4285-4287-4289-4291-4293-4295-4297-4299-4301-4303-4305-4307-4309-4311-4313-4315-4317-4319-4321-4323-4325-4327-4329-4331-4333-4335-4337-4339-4341-4343-4345-4347-4349-4351-4353-4355-4357-4359-4361-4363-4365-4367-4369-4371-4373-4375-4377-4379-4381-4383-4385-4387-4389-4391-4393-4395-4397-4399-4401-4403-4405-4407-4409-4411-4413-4415-4417-4419-4421-4423-4425-4427-4429-4431-4433-4435-4437-4439-4441-4443-4445-4447-4449-4451-4453-4455-4457-4459-4461-4463-4465-4467-4469-4471-4473-4475-4477-4479-4481-4483-4485-4487-4489-4491-4493-4495-4497-4499-4501-4503-4505-4507-4509-4511-4513-4515-4517-4519-4521-4523-4525-4527-4529-4531-4533-4535-4537-4539-4541-4543-4545-4547-4549-4551-4553-4555-4557-4559-4561-4563-4565-4567-4569-4571-4573-4575-4577-4579-4581-4583-4585-4587-4589-4591-4593-4595-4597-4599-4601-4603-4605-4607-4609-4611-4613-4615-4617-4619-4621-4623-4625-4627-4629-4631-4633-4635-4637-4639-4641-4643-4645-4647-4649-4651-4653-4655-4657-4659-4661-4663-4665-4667-4669-4671-4673-4675-4677-4679-4681-4683-4685-4687-4689-4691-4693-4695-4697-4699-4701-4703-4705-4707-4709-4711-4713-4715-4717-4719-4721-4723-4725-4727-4729-4731-4733-4735-4737-4739-4741-4743-4745-4747-4749-4751-4753-4755-4757-4759-4761-4763-4765-4767-4769-4771-4773-4775-4777-4779-4781-4783-4785-4787-4789-4791-4793-4795-4797-4799-4801-4803-4805-4807-4809-4





Copyright 2024

หน้าหลัก...

เกี่ยวกับสมาคม

กิจกรรมสมาคม

แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

ของที่ระลึก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมาคม



Display #

10

Search ...

SEARCH

Title	Author	Hits
คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ	Written by: Super User	4024
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกวารสาร	Written by: Super User	3431
รวมวารสารสมาคม	Written by: Super User	3216

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 1/237 อาคารสโตนแอนด์เทอเรส

ก.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก

จ.กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02-6320003

เบอร์แฟกซ์ 02-6320004

เบอร์ติดต่อมือถือ 087-113-2270

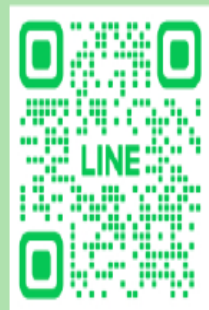
Line ID OA @195capnq

เว็บไซต์ www.tpna.or.th

E-mail : tpna.or.th@hotmail.com

tpna.association@gmail.com

LINE OA



<https://lin.ee/DEwKZgK>



908260

Today	140
Yesterday	259
This Week	2224
Last Week	5552
This Month	5897
Last Month	890275
All days	908260

Your IP: 172.68.241.76

2024-02-10 13:26

Visitors Counter

**บทความทางวิชาการ
ลงวารสาร สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด
แห่งประเทศไทย**



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลประเภทหน่วยงาน
และ/หรือ เสนอขอรับรางวัลประเภทนวัตกรรม

(นวัตกรรมดีเด่น นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร และนวัตกรรมดีเด่นด้านความเป็นเลิศ)

นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดตาม



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

135 Years Siriraj

โครงการ
ติดตาม
ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนชาวศิริราชส่งผลงานเสนอขอรางวัล
โครงการติดตาม ประจำปี 2567
ประเภทหน่วยงาน และประเภทนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 1 มี.ค. 67

Download

เกณฑ์รางวัลฯ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้ที่
Website งานพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ
โทร. 98764 ต่อ 104

เกณฑ์ตัดสินการให้รางวัล 5 ด้าน

- 1) ตรงกับจุดเน้นของคณะฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ
- 2) มีการปรับปรุงให้ได้ $>50\%$
 - ต่างจากของเดิม
 - มีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ KPI
- 3) ผลลัพธ์แสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 - ดีขึ้นจริง มีแนวโน้มดีขึ้น
- 4) การดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นมาตรฐานการทำงาน
 - PDCA อย่างน้อย 3 รอบ
- 5) การขยายผลต่อยอดนวัตกรรมไปหน่วยงานอื่นได้

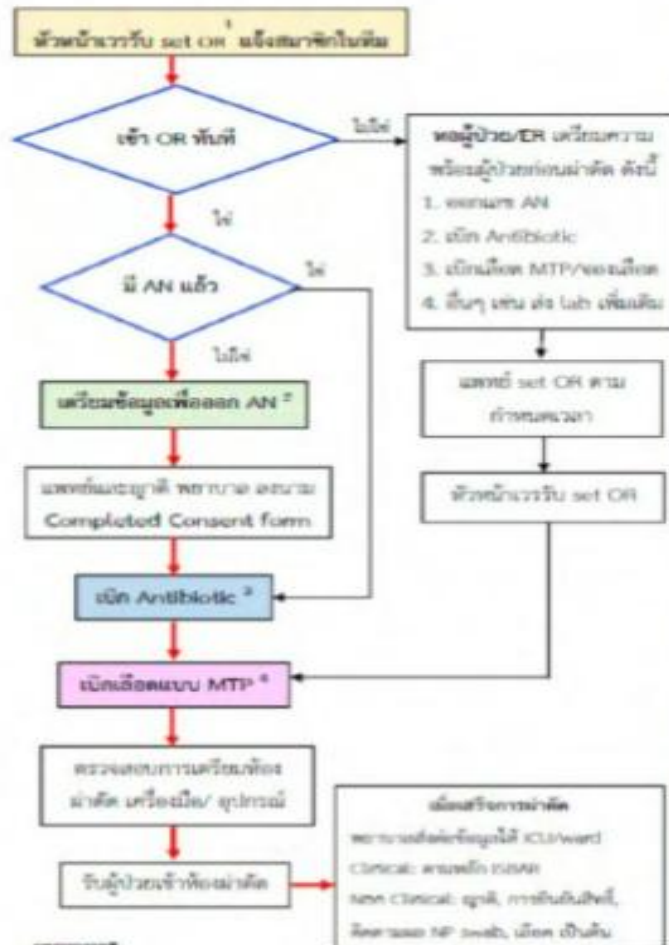
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ตอบสนองต่อ **ปัญหาสำคัญ** ของหน่วยงาน/**คณะ**/ประเทศ สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ให้บริการ และคณะฯ ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่ชัดเจน (รวม 5 คะแนน)
2. กระบวนการพัฒนา (รวม 9 คะแนน)
 - 2.1 **วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด** ของการพัฒนานวัตกรรม มีความ**สอดคล้องกับบริบท**ของหน่วยงาน/ทีม นำ/คณะฯ (4 คะแนน)
 - 2.2 วิธีการพัฒนานวัตกรรม (Plan-Do-Check-Act) เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน/คณะกรรมการ/ทีมทางคลินิก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้น/เข้มแข็งของคณะฯ/โรงพยาบาล/ทีมทางคลินิก/ภาควิชา (5 คะแนน)
3. ผลลัพธ์ของนวัตกรรม (รวม 11 คะแนน) **การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด**
 - 3.1 ผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรมที่แสดงถึง **ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีแนวโน้มดีขึ้น** (5 คะแนน)
 - 3.2 ผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมต่อหน่วยงาน/คณะฯ (6 คะแนน)
มีการใช้จริงเป็นงานประจำ/ มาตรฐานการทำงาน
4. ผลลัพธ์ด้านการใช้ทรัพยากร (อาจเป็นกำลังคน เวลา ค่าใช้จ่าย โดยต้องแสดงเป็นมูลค่า มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน และหลังการพัฒนานวัตกรรม) ประหยัดการใช้ทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนานวัตกรรม (รวม 5 คะแนน)

โครงการ Perioperative Workflow of RAAA for Nurse



พว.วิจิตรา สังชะโห, PI



ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย * นำตัวผู้ป่วยมาพร้อมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย set OR ครึ่งที่ 1 1. ชื่อ-นามสกุล, พ.ช, สัญชาติการแพทย์ 2. Clinical condition (On ET Tube?) 3. Past operation และ special treatment (ถ้ามี) 4. จัดแพทย์ผู้ดูแล 5. พญ.ผู้ป่วยจะ Admit ผู้ป่วย เพื่อเตรียมข้อมูลก่อน AN 6. Antibiotic ที่จะใช้ให้ก่อนผ่าตัด 7. Hb Actualized MTP 8. Rapid Ag test ในห้องผ่าตัด 9. จัดแพทย์ผู้ดูแล set OR และแพทย์ช่วยชีวิตในห้อง 10. เวลาที่ผู้ป่วยจะออกจากห้องผ่าตัด และรายการแพทย์ในห้อง ครึ่งที่ 2 เมื่อผู้ป่วยมาถึง OR สัปดาห์ที่ 30 นาที	ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อน AN * 1. ประสานงานพญ.ผู้ป่วยกับ Admit เพื่อ confirm และเตรียม bed 2. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำผู้ป่วยไป OR กรณีผู้ป่วยไม่ผ่านการประเมิน ประเมินผู้ป่วยไม่ปกติ กรณีผู้ป่วยมีปัญหา เช่น มีไข้, ชามสูง ส่งไปให้ทีมดูแลผู้ป่วยแล้ว 3. กรณีมีไข้สูง, sepsis, coagulopathy พบ sepsis, coagulopathy จัดทีม 2 เมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัด 1. ประสานงานกับห้องตรวจเลือดเพื่อได้ CPT 101 โทร. 9-7234-5 เพื่อส่ง AN โดยกำหนดเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 2. Pre study name 20 ใบ 3. แนะนำญาติให้มาพบแพทย์ในห้องผ่าตัด CPT 103 (ถ้าทำได้)
	ขั้นตอนการเก็บ Antibiotic * 1. โทร. ไปห้องปฏิบัติการ 2. แพทย์ เก็บยา Antibiotic ที่ห้อง 3. ประสานงานเพื่อส่งยาไปห้อง 9-7311 เพื่อตรวจสอบ 4. 30min สำหรับผลการวิเคราะห์ และเขียนใบเก็บยา 5. พญ.ผู้ป่วยจะไปห้องผ่าตัดเพื่อส่งยาในห้องผ่าตัด
	ขั้นตอนการเก็บเลือดแบบ MTP * 1. แพทย์ Activate MTP โทร. 9-7098-9 แจ้ง Blood Bank 2. เขียนแบบบันทึกการเก็บ MACROVE TRANSFUSION PROTOCOL (เขียนพารามิเตอร์) 3. เขียนใบส่งตรวจเลือด 4. พญ.ผู้ป่วยจะไปห้องผ่าตัดเพื่อส่งยาในห้องผ่าตัด * เมื่อส่ง MTP และแพทย์ในห้อง OR check match แล้วส่ง ECG, 6 lead, water ที่ 2 ไปให้ blood bank, ระบุเลือด 20 นาที

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สืบค้นข้อมูลและทบทวนการทำงาน พร้อมจัดทำร่างโครงการฯ
2. ประชุมทีมเพื่อชี้แจงโครงการฯ
3. จัดทำแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดในการผ่าตัดฉุกเฉิน AAA สำหรับพยาบาลหัวหน้าเวร On Call (ภาพที่ 1)
4. จัดทำแนวปฏิบัติในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด Open Repair AAA และ EVAR (ภาพที่ 2)
5. ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 3, 4 เมื่อมีผู้ป่วยผ่าตัด
6. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 1)
7. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
8. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 2)
9. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
10. เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด (ครั้งที่ 3)
11. นำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ
12. เขียนสรุปโครงการฯ

หมายเหตุ *

1) ตัวนำผู้ป่วยประสานงานกับแพทย์ผู้ดูแล set OR 2 ครึ่ง

ครึ่งที่ 1 กรณีผู้ป่วยมีไข้สูง/สัญญาณชีพผิดปกติ set OR ส่วนตัวนำส่วนที่ 2 กรณีผู้ป่วยมีไข้สูง/สัญญาณชีพผิดปกติ set OR ส่วนตัวนำส่วนที่ 2 กรณีผู้ป่วยมีไข้สูง/สัญญาณชีพผิดปกติ

ครึ่งที่ 2 เมื่อผู้ป่วยมาถึง OR สัปดาห์ที่ 30 นาที

2) การเตรียมห้องผ่าตัด เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ให้แพทย์ผู้ดูแลในห้องผ่าตัดก่อนนำผู้ป่วยมาผ่าตัด

3) กรณีมีไข้สูง/สัญญาณชีพผิดปกติ Rapid Ag test ในห้องผ่าตัด เก็บ Hb โทร. 9-7005 ตามปกติ และ เก็บ Hb ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์ 2-4 อย่างพร้อม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์ก่อน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. อัตราห้องผ่าตัดจัดเตรียมพร้อม สำหรับการผ่าตัดภายใน 30 นาที (%)	100	70	75	83.4	100
2. อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ป่วยใน ขั้นตอนการรับ set ผ่าตัด (%)	≥90	NA	80	90	98
3. อัตราผู้ป่วยได้รับการออก AN ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงห้องผ่าตัด (%)	≥90	50	75	100	100
4. อัตราผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะก่อน ผ่าตัดภายใน 60 นาที ก่อนลงมีด ผ่าตัด (%)	≥90	NA	50	100	100
5. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการ ขอ MTP (ครั้ง)	0	1	0	0	0
6. อุบัติการณ์ความล่าช้าในการผ่าตัด เนื่องจากการจัดวางอุปกรณ์ผิด ตำแหน่ง (ครั้ง)	0	1	0	0	0

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน/ขยายผล

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ Fast Track RAAA โดยใช้ Lean Concept โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมห้องผ่าตัดที่ OR ศูนย์โรคหัวใจชั้น 5 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกล่องอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วย RAAA ที่ติดเชื้อ COVID-19

ปรับปรุงจากที่มีแล้ว ก็ % 50% → **1-2**

สอดคล้องกับหน่วยงาน/ จุดเน้น?
2-3

มีข้อมูล baseline มีแผน/ ประเมิน/
ปรับปรุง? **3**

มีตัวชี้วัดบรรลุผล? **3**
4 ถ้าเป็นตัวชี้วัดหลักของ ทีมนำ/คณะ

ต่อยอดในคณะ? **2**

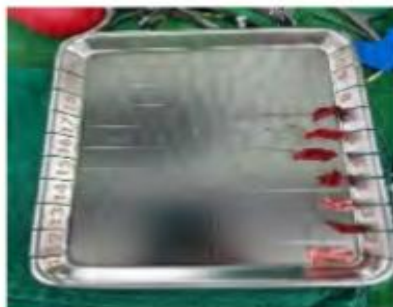
ใช้ทรัพยากรลดลง? **1-2**

คะแนนรวม 14-15 คะแนน

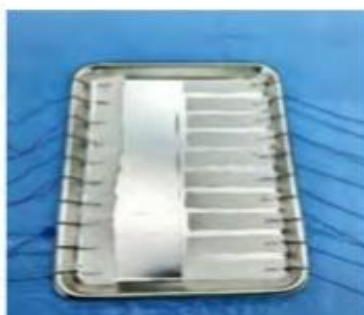
Noid หนูครบจบได้



พว.ธนพรรณ กุณาสะสิริ, PI



ภาพที่ 1 นวัตกรรมถาดวาง Cottonoid



ปรับปรุงจากที่มีแล้ว ก็ % 50% → 2

สอดคล้องกับหน่วยงาน/ จุดเน้น? 2-3

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์ก่อน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. อุบัติการณ์สำหรับข้อผิดพลาดในแผลผ่าตัด (ครั้ง)	0	1	0	0	0
2. ระยะเวลาในการนับสำลีซับโลหิต (>20 ชิ้น) ในขณะที่ผ่าตัด (นาที)	2	5	2	1	1
3. อัตราความพึงพอใจของทีมผ่าตัดในการนับสำลีซับโลหิตในขณะที่ผ่าตัด (%)					
- แพทย์	90	NA	80	90	90
- พยาบาลห้องผ่าตัด	90	NA	80	85	90

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน/ขยายผล

สามารถนำไปขยายผลในหน่วยงานห้องผ่าตัดสาขาอื่นๆ ที่มีการใช้สำลีซับโลหิตในขณะที่ผ่าตัด

มีข้อมูล baseline มีแผน/ ประเมิน/ ปรับปรุง? 3

มีตัวชี้วัดบรรลุผล? 3-4 ถ้าเป็นตัวชี้วัดหลักของคณะ

ต่อยอดในคณะ? 2

ใช้ทรัพยากรลดลง? 1-2

คะแนนรวม 13-14 คะแนน

สรุป

**Pain
Point!!**

CQI

ตั้งประเด็นที่ใช้และชัดเจน
(ข้อมูลเชิงประจักษ์, สถิติ, มาตรฐาน, อ้างอิง)

ออกแบบ สร้าง นวัตกรรม
(Process & Product ที่แก้ปัญหา)

ทดลองใช้/ พิสูจน์จริง
(กำหนดตัวชี้วัด และการเก็บข้อมูล)

ขยายผลภายใน/ ภายนอกองค์กร

ข้อแนะนำ



- ❖ ดูช่วงเวลาในการพัฒนางานให้ดี วางแผน Time line
- ❖ ไม่ควรสร้างนวัตกรรมที่ ขัดต่อหลัก **ความปลอดภัยผู้ป่วย** human factors แนวทางปฏิบัติหลัก หรือเพิ่มความซับซ้อนโดยไม่สามารถแสดงประโยชน์ได้ชัดเจน
- ❖ ต้องแสดงให้เห็นว่า กระบวนการใหม่/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนรูปแบบของวัสดุ และเป็นเพียงส่วนประกอบของการนำไปใช้
- ❖ อย่าลืม **ผลลัพธ์ก่อนดำเนินการ**
- ❖ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ต้องมีการพัฒนารูปแบบจนทำให้ user-friendly หรือมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
- ❖ Workflow ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติจนเป็นงานประจำ (Routine work) และมีผลลัพธ์ให้เห็น
- ❖ อาจแบ่งโครงการเป็นระยะ (Phase) ได้ เช่น ตามกลุ่มผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- ตอบสนองตรงกับปัญหา/ ความต้องการ
- มีความเหมาะสม และ ปลอดภัยกับกลุ่มเป้าหมาย
- ถูกต้องตามหลักวิชา มีโอกาสเกิดผลบวกค่อนข้างสูง

Job Assignment



หลักสูตรเฉพาะทางปริศัลยกรรม 4 เดือน

จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพในกลุ่มผู้ปวยเฉพาะสาขา

รายกลุ่มทั้งหมด 9 -10 กลุ่ม

กลุ่มละ 4-5 คนตามสาขา

นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มที่ 1-5

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มที่ 6-10

กลุ่มละ 1 ชั่วโมง

(นำเสนอ 40 นาที และรับฟังข้อเสนอแนะจาก Commentator 20 นาที)

ส่งรายงานวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 8:00-12:00น. ที่ Preceptor หลักแต่ละสาขา



จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติ

- หน่วยผ่าตัดจักษุฯ 5 คน
- หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ 6 คน
- หน่วยผ่าตัดโสตฯ 5 คน
- หน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 6 คน
- หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ 5 คน
- หน่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะ 4 คน
- หน่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช 5 คน
- หน่วยผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป 12 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

รวม 48 คน

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม เพื่อ

- 1) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์
- 2) การเรียบเรียงเนื้อหา สกัด และสรุปสาระสำคัญ
- 3) การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเพื่อระดมความคิดเห็น
- 4) เทคนิคการนำเสนองานเชิงวิชาการ
- 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการ
- 6) การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

จัดกลุ่มทำ CQI project 9 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน

หลักสูตรเฉพาะทางปริศัลยกรรม 4 เดือน



กำหนดการนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กลุ่มที่	โครงการพัฒนาคุณภาพ	สาขา
จ.ที่ 12 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2569 Clinical Practice (5 สัปดาห์) * แจ้งชื่อโครงการและลำดับการนำเสนอล่วงหน้า				
พ.ท.ที่ 12 พฤศจิกายน 2569	8:30-9:30น.	1		
	9:30-10:30น.	2		
	10:30-11:30น.	3		
	13:00-14:00น.	4		
	14:00-15:00น.	5		
	15:00-16:00น.		Self study สรุปงานกลุ่ม	
ศ.ที่ 13 พฤศจิกายน 2569	8:30-9:30น.	6		
	9:30-10:30น.	7		
	10:30-11:30น.	8		
	13:00-14:00น.	9		
	14:00-15:00น.		Self study สรุปงานกลุ่ม	
	15:00-16:00น.			
ศ.ที่ 20 พฤศจิกายน 2569	8:00-12:00น.	ส่งรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพที่ Preceptor หลักแต่ละสาขา		



หลักสูตรเฉพาะทางปริศัลยกรรม 4 เดือน

แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะสาขา

นำเสนอ วันที่

โดยวิทยากรภาคปฏิบัติ (30%)

โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อประเมิน	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาชัดเจน					
2. การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา/ ปัญหา					
3. การทบทวนองค์ความรู้ได้ครอบคลุม					
4. การดำเนินงานเหมาะสม					
5. การเก็บตัวชี้วัด และวิเคราะห์ผลถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์					
6. ผลลัพธ์ส่งผลต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยตรง					
7. การนำเสนอมีความชัดเจน					
8. ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม					
9. ความสมบูรณ์ของรายงาน (กำหนดส่งรายงานวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ภายในเวลา 12:00น.)					

โครงการพัฒนาคุณภาพ **รายบุคคล** 18 คน



การนำเสนอ 10 เรื่อง โดยการสุ่ม
เรื่องละ 7-10 นาที
และ Commentator 2 คน/1 เรื่อง

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00-16.00น.
ห้องประชุมใหญ่ งานการพยาบาลผ่าตัด ตึกสยามินทร์ชั้น 10



แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลปริศัลยกรรม

นำเสนอ วันที่

โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง

หัวข้อประเมิน	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาชัดเจน					
2. การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา/ ปัญหา					
3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรร					
4. การกำหนดตัวชี้วัดตรงตามวัตถุประสงค์					
5. ความปลอดภัย มีการอ้างอิงงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ					
6. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และความคุ้มค่า					
7. การนำเสนอมีความชัดเจน					
8. ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม					
9. ความสมบูรณ์ของรายงาน (กำหนดส่งรายงานวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ภายในเวลา 12:00น.)					

Any Question?



Thank You
for Your Attention

